

Manual de apoio para análise de Fisioterapia

Qualidade, Treinamento & Capacitação

Departamento de Serviços de Reembolso ao Segurado

bradesco saúde

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO E CONSIDERAÇÕES GERAIS 6

FISIOTERAPIA PARA APÓLICE LIVRE ESCOLHA 8

ATENDIMENTOS REMOTOS 9

TÉCNICAS FISIOTERÁPICAS 10

Técnicas não cobertas 11

Técnicas com observações especiais 12

R.P.G - Reeducação Postural Global 17

Estimulação Elétrica Transcutânea (TENS) 18

PEDIDO MÉDICO X COBRANÇA 25

CÓDIGOS DE FISIOTERAPIA E SUAS APLICAÇÕES 28

Consulta fisioterápica 29

TUSS 50000144 - Consulta ambulatorial em fisioterapia 29

TUSS 50000349 - Consulta hospitalar em fisioterapia 30

Códigos de teleatendimento 30

Códigos de membro 31

TUSS 20103484 - Patologia osteomioarticular em um membro 31

TUSS 20103492 - Patologia osteomioarticular em dois ou mais membros 32

TUSS 20103298 - Hipo ou agenesia de membros 32

Códigos de coluna 33

TUSS 20103506 - Patologia osteomioarticular em um segmento da coluna 33

TUSS 20103514 - Patologia osteomioarticular em diferentes segmentos da coluna 34

TUSS 20103182 - Desvios posturais da coluna vertebral 34

Código de pós-operatório 35

TUSS 20103093 - Atendimento fisiátrico no pré e pós-operatório de pacientes para prevenção de sequelas 35

Códigos de reabilitação perineal ou pré/pós-parto 36

TUSS 20103565 - Processos inflamatórios pélvicos 36

TUSS 20103190 - Disfunção vesico-uretral 36

TUSS 20203020 - Eletroestimulação do assoalho pélvico e/ou outra técnica de exercícios perineais 37

TUSS 20103107 - Atendimento fisiátrico no pré e pós-parto 38

TUSS 20103646 - Reabilitação perineal com biofeedback 39

TUSS 20103131 - Biofeedback com EMG 40

Códigos de fisioterapia respiratória/cardiopulmonar 41
TUSS 20103220 - Doenças pulmonares atendidas em ambulatório 41
TUSS 20103360 - Paciente com D.P.O.C. em atendimento ambulatorial necessitando reeducação e reabilitação respiratória 41
TUSS 20103255 - Exercícios para reabilitação do asmático (ERAI) - por sessão individual 42
TUSS 20103069 - Assistência fisiátrica respiratória em pré e pós-operatório de condições cirúrgicas 42
TUSS 20103719 - Sinusites 42
Códigos de fisioterapia em regime de internação 43
TUSS 20203047 - Assistência fisiátrica respiratória em doente clínico internado 43
TUSS 20203012 - Assistência fisiátrica respiratória em paciente internado com ventilação mecânica 43
TUSS 20203071 - Pacientes em pós-operatório de cirurgia cardíaca, hospitalizado, até 8 semanas de programa 44
TUSS 20203063 - Pacientes com doença isquêmica do coração, hospitalizado, até 8 semanas de programa 44
TUSS 50000365 - Atendimento fisioterapêutico hospitalar ao paciente com disfunção decorrente de alterações do sistema músculo-esquelético 45
TUSS 50000390 - Atendimento fisioterapêutico hospitalar ao paciente com disfunção decorrente de queimaduras 45
TUSS 50000403 - Atendimento fisioterapêutico hospitalar ao paciente com disfunção decorrente de alterações do sistema linfático e/ou vascular periférico 46
TUSS 50000454 - Atendimento fisioterapêutico hospitalar para alterações inflamatórias e ou degenerativas do aparelho genito-urinário, reprodutor e/ou proctológico 46
TUSS 50000799 - Atendimento fisioterapêutico hospitalar ao paciente independente ou com dependência parcial, com disfunção decorrente de lesão do sistema nervoso central e/ou periférico 47
TUSS 50000802 - Atendimento fisioterapêutico hospitalar ao paciente dependente com disfunção decorrente de lesão do sistema nervoso central e/ou periférico 47
Códigos de fisioterapia cardiovascular 48
1. Conceito Geral e Definições da Reabilitação Cardiovascular (RCV) 48
2. Estrutura, Fases e Componentes da RCV 49
3. Interpretação dos Códigos TUSS na Perspectiva da RCV 51
TUSS 20103379 - Paciente em pós-operatório de cirurgia cardíaca, atendido em ambulatório, duas a três vezes por semana 51

TUSS 20103395 - Pacientes com doença isquêmica do coração, atendido em ambulatório, até 8 semanas de programa 51

TUSS 20103387 - Pacientes com doença isquêmica do coração, atendido em ambulatório de 8 a 24 semanas 52

TUSS 20103417 – Pacientes sem doença coronariana clinicamente manifesta, mas considerada de alto risco, atendido em ambulatório, duas a três vezes por semana 52

TUSS 20103727 - Reabilitação cardiovascular supervisionada. Programa de 12 semanas. Duas a três sessões por semana (por sessão) 53

Código de fisioterapia linfática 53

TUSS 20103212- Distúrbios circulatórios artério-venosos e linfáticos 53

Código de reeducação e/ou reabilitação de distúrbios craniofaciais 54

TUSS 20103654 - Recuperação funcional de distúrbios crânio-faciais 54

Códigos de reeducação e reabilitação neuro-músculo-esquelética 55

TUSS 20103271 - Hemiplegia 55

TUSS 20103263 - Hemiparesia 55

TUSS 20103328 - Lesão nervosa periférica afetando um nervo com alterações sensitivas e/ou motoras 56

TUSS 20103310 - Lesão nervosa periférica afetando mais de um nervo com alterações sensitivas e/ou motoras 56

TUSS 20103344 – Miopatias 57

TUSS 50000160 - Atendimento fisioterapêutico ambulatorial ao paciente com disfunção decorrente de alterações do sistema músculo-esquelético 58

TUSS 20103409 - Pacientes com doenças neuro-músculo-esqueléticas com envolvimento tegumentar 59

Códigos de reeducação e reabilitação neurológica 60

TUSS 20103077 - Ataxias 60

TUSS 20103204 - Distrofia simpático-reflexa 60

TUSS 20103425 - Paralisia cerebral 61

TUSS 20103441 - Paraparesia/tetraparesia 61

TUSS 20103450 - Paraplegia e tetraplegia 62

TUSS 20103468 - Parkinson 62

TUSS 20103476 - Patologia neurológica com dependência de atividades da vida diária 63

Códigos de reeducação e reabilitação no retardo do desenvolvimento psicomotor 64

TUSS 20103689 - Retardo do desenvolvimento psicomotor 64
TUSS 50000012 - Sessão de psicomotricidade individual 64
Código de reabilitação labiríntica 65
TUSS 20103638 - Reabilitação labiríntica (por sessão) 65
Códigos de exercícios de ortóptica 66
TUSS 20103239 - Exercícios de ortóptica (por sessão) 66
TUSS 20103743 - Exercícios de pleóptica 67
Código de reeducação e reabilitação de queimados para prevenção de sequelas 68
TUSS 20103611 - Queimados - seguimento ambulatorial para prevenção de sequelas (por segmento) 68
Códigos de reabilitação em amputação (preparação do coto e treinamento protético) 69
TUSS 20103042 - Amputação unilateral (preparação do coto) 69
TUSS 20103026 - Amputação bilateral (preparação do coto) 69
TUSS 20103034 - Amputação bilateral (treinamento protético) 69
TUSS 20103050 - Amputação unilateral (treinamento protético) 69
UTILIZAÇÃO DE CRÍTICAS 70

INTRODUÇÃO E CONSIDERAÇÕES GERAIS

Este manual foi desenvolvido com o objetivo de **padronizar a análise de solicitações de fisioterapia**, garantindo consistência e transparência nos processos. Sabemos que existem muitas dúvidas e divergências na interpretação das regras, especialmente diante da variedade de técnicas e cenários clínicos. Por isso, este material busca oferecer **orientações claras e práticas**, servindo como referência para toda a equipe na tomada de decisão, sempre alinhado às normas vigentes e às melhores práticas do setor.



📌 Há cobertura para todas as apólices da lei com *segmentação ambulatorial*. Já para as somente *hospitalares + obstetrícia*, a cobertura é limitada a continuidade da assistência prestada durante a internação hospitalar, conforme art. 19, Inciso X, alínea J da RN 465.
Exemplos:

✅ Um paciente internado para tratamento de pneumonia continua a fisioterapia respiratória após a alta hospitalar.
✅ Após uma cirurgia de prótese de quadril, o paciente segue com fisioterapia para reabilitação.
✅ Um paciente com AVC que recebeu fisioterapia motora durante a internação continua o tratamento após a alta.

📌 **A fisioterapia convencional** é paga de acordo com a patologia descrita no pedido do médico assistente. O relatório do fisioterapeuta não substitui o encaminhamento do médico, porém serve como documento complementar para a análise técnica dos eventos, podendo: elucidar as metodologias empregadas, a região corporal da aplicação da técnica, endereço em que ocorreram os atendimentos, datas das sessões, entre outros.

📌 Nas apólices da Lei e Adaptadas, utilizamos códigos da tabela **TUSS**. Para as pré-lei, da tabela **THSM**.

📌 A cobertura está condicionada a realização por **fisioterapeutas** ou médicos **fisiatras**, conforme consta no artigo nº 18 da RN465/ANS.

📌Deve sempre haver pedido médico emitido por CRM ou cirurgião-dentista assistente, com data, carimbo e assinatura (física ou digital), contendo o quadro clínico e indicação.

➡️Referente a CRO, o dentista pode solicitar procedimentos que são necessários ao diagnóstico, tratamento e prognóstico odontológicos, conforme inciso I, art. 4º da RN 465. Ou seja, que sejam relacionados a sua área de atuação: cabeça e pescoço.

📌Na documentação deve haver informação do profissional executante, com número de registro no conselho de classe, além das datas de todas as sessões.

📌 Para apólices anteriores à lei, sem adaptação e sem aditivos (ampliação de cobertura ou compreensiva), a cobertura para fisioterapia é limitada a casos de acidente pessoal, não incluindo doenças.

> 💡 No entanto, para casos no estado da **Bahia**, uma ação civil pública (ACP) de 2008 (processo judicial 1947323-9/2008) impede a negativa de cobertura para fisioterapia por doença, mesmo que esteja excluída pelo contrato. *Nos demais estados, continuaremos a negar com a crítica* ***N225***;

📌 Para todo o país (ACP processo judicial 2001/02289-9), não podemos limitar a quantidade de procedimentos de fisioterapia. Ou seja, não se impõe o limite de 40 sessões, desde que a apólice tenha cobertura para o procedimento. Por exemplo, apólices que não têm cobertura para fisioterapia por doença continuarão sem cobertura, mas aquelas que têm cobertura para 40 sessões passarão a ser ilimitadas em quantidade.

📌 Se pré-lei com aditivos (seja compreensiva, ampliação de cobertura ou cláusula contratual), há cobertura para fisioterapia por doença e utilizaremos os códigos **THSM**.

📌 A cobertura para fisioterapia domiciliar é restrita a alguns casos, mas para a maioria não há cobertura. Saiba mais no material POP 017 – Eventos em Domicílio.

📌 Fisioterapeuta pessoa física deve emitir Receita Saúde. Exigimos para eventos a partir de 01/03/2025.

FISIOTERAPIA PARA APÓLICE LIVRE ESCOLHA

A cobertura para fisioterapia depende do tipo de apólice e da situação do paciente (internado ou ambulatorial). **Atenção: se houver cobertura, sempre será ilimitada por conta da Ação Civil Pública**! Seguem as regras normativas:

Fisioterapia por Doença

- **Paciente internado:**
  - Há cobertura durante toda a internação. Liberar pela Tabela **MPAS/79** se a apólice não tiver adaptação, com ou sem ampliação de cobertura.
  - **Se adaptada,** utilizar a **TUSS/MPAS.**

- **Paciente ambulatorial:**

  - **Com consultas e exames, mas sem adaptação ou ampliação:**
    - Há cobertura, liberar pela **THSM**.

  - **Com consultas e exames, e for adaptado:**
    - Há cobertura. Se fisioterapia **não relacionada** à continuidade de internação hospitalar, pagar por conta do Consulta e Exame (CE) e liberar pela **TUSS** (alterar para fator 1 na calculadora).
    - Se **for relacionada à continuidade de internação hospitalar**, liberar pela tabela **TUSS/MPAS**.

  - **Com consultas e exames, e for ampliado, mas sem adaptação:**
    - Há cobertura. Se **não relacionada** à continuidade da internação hospitalar, liberar pela **THSM**.
    - Se **relacionada** à continuidade da internação hospitalar, liberar pela **MPAS/79**.

  - **Sem consultas e exames, e for ampliado, mas sem adaptação:**
    - Se **for relacionada à continuidade da internação hospitalar**, há cobertura e será liberado pela tabela **MPAS/79**.
    - Se **não for relacionada** à continuidade de internação, não há cobertura, **negar** (olhar o contrato, se houver exclusão, negar com **N225**).

  - **Sem consultas e exames, e for adaptado:**
    - Se **for relacionada à continuidade da internação hospitalar**, há cobertura e será liberado pela tabela **TUSS/MPAS**.
    - Se **não for relacionada** à continuidade de internação, não há cobertura, **negar** (olhar o contrato, se houver exclusão, negar com **N225**).

  - **Sem consultas e exames e sem adaptação ou ampliação:**
    - **Negar** (olhar o contrato, se houver exclusão, negar com **N225**).



Fisioterapia por Acidente

- **Paciente internado:**
  Há cobertura. Se não adaptada, liberar pela Tabela **MPAS/79**. Se adaptada, liberar pela **TUSS/MPAS**.

- **Paciente ambulatorial:**

  - **Com ou sem consultas e exames, sem adaptação/ampliação:**
    - ❖ Há cobertura. Liberar conforme Tabela **MPAS/79**.

  - **Com ou sem consultas e exames, se adaptado:**
    - ❖ Há cobertura. Liberar pela Tabela **TUSS/MPAS.**

  - **Com ou sem consultas e exames, se ampliado sem adaptação:**
    - ❖ Há cobertura. Liberar pela Tabela **MPAS/79**.

ATENDIMENTOS REMOTOS

Em 09/07/2025, foi publicada a Resolução COFFITO Nº 619/2025, que substitui a Resolução COFFITO Nº 516/2020 e amplia a área de atuação do fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. Pontos principais:



📌 A inclusão de **teleatendimento (sessão online de fisioterapia ou terapia ocupacional)**, além da teleconsulta, teleconsultoria e telemonitoramento previstos na resolução anterior;

📌 Estabelece a **regulamentação permanente** da telessaúde, sendo a anterior de caráter temporário.

📌 Determina que o profissional **mantenha o prontuário atualizado** a cada atendimento remoto.

📌 Dispensa **inscrição secundária** para atuação remota em outras regiões.

📌 Deixa claro que **o atendimento remoto não substitui consultas e avaliações clínicas presenciais,** quando estas forem indispensáveis ao diagnóstico ou tratamento.

⚠️ A Resolução é válida para eventos a partir de 09/07/2025. Para eventos anteriores, será praticada a rotina já estabelecida: não reembolsaremos teleatendimento (**N353**).

💡 A lista de códigos de teleatendimento está na seção Códigos de fisioterapia.

Como diferenciar esses atendimentos de uma sessão convencional?

Telemonitoramento: acompanhamento à distância de paciente **atendido previamente de forma presencial**, por meio de aparelhos tecnológicos. Nesta modalidade, o fisioterapeuta ou terapeuta Ocupacional pode utilizar métodos síncronos (comunicação a distância realizada em tempo real) ou assíncronos (comunicação a distância não realizada em tempo real). Pode decidir sobre a necessidade de encontros presenciais para a reavaliação sempre que necessário, que podem ser feitos, de comum acordo, por outro fisioterapeuta ou TO local.

Teleconsultoria: comunicação registrada e realizada entre profissionais, gestores e outros interessados da área de saúde, fundamentada em evidências clínico-científicas e em protocolos disponibilizados pelo Ministério da Saúde e pelas Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, com o fim de esclarecer dúvidas sobre procedimentos clínicos, ações de saúde e questões relativas ao processo de trabalho.

Teleconsulta: consulta clínica registrada e realizada pelo fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional à distância.



Teleatendimento: utilização de meios digitais de comunicação para a realização de intervenção em Fisioterapia ou Terapia Ocupacional de forma remota, seja de modo exclusivo ou como complemento à intervenção presencial.

TÉCNICAS FISIOTERÁPICAS

Algumas técnicas e metodologias terapêuticas não são de cobertura obrigatória. Para apólices adaptadas à legislação de segmentação ambulatorial, essas práticas não integram o rol de procedimentos da ANS (**N205**). Já nas apólices anteriores à legislação, elas não constam na tabela de reembolso (**N336**).
A seguir, apresentamos a lista catalogada de técnicas.

🚨 Em caso de técnica não listada e passível de não cobertura, levar à consultoria para avaliação. E por fim, levar à Qualidade/Gerência Médica para tomada de decisão e implementação na rotina.

⚠️ Importante: as empresas podem oferecer cobertura excepcional para a técnica.
Antes de qualquer negativa, é fundamental:

- Verificar se o segurado possui liminar médica vigente contemplando a terapia ou autorizações da empresa em F6/F8.
- Consultar em F7-F9 ou na aba Condições Gerais do SCAM se há cobertura adicional para procedimentos que normalmente não são obrigatórios.

Exemplos de empresas com excepcionalidades:

a) **ANBIMA**: cobertura para HIDROTERAPIA e PILATES
b) **IBM** e **KYNDRYL**: cobertura para PILATES

🎯 Liberação conforme patologia.



Técnicas não cobertas

As técnicas a seguir devem ser negadas, conforme especificado anteriormente (N205 para apólice da lei e N336 para pré-lei). Em caso de técnica não catalogada e com possibilidade de ser não coberta, levar o caso à consultoria para avaliação. Por fim, deve ser reportado à Qualidade/Gerência Médica para decisão e inclusão na rotina.

📌 **Atividade de Escola de postura:** Programa de exercícios e educação postural que visa corrigir hábitos inadequados e prevenir problemas de coluna.

📌 **Colocação de Taping/ Kinesio Taping:** Aplicação de fita elástica adesiva sobre a pele para suporte muscular e articular, melhora da circulação, redução de dor e auxílio na reabilitação, sem restringir movimentos.

📌 **Equoterapia:** Terapia que utiliza cavalos para promover a reabilitação física e emocional, melhorando a coordenação, equilíbrio e força muscular. (Obs.: atenção para liminares!).

📌 **Fisioterapia robótica (lokomat)/ reabilitação robótica:** A fisioterapia robótica, também conhecida como Lokomat, é um tipo de terapia de reabilitação que utiliza um exoesqueleto robótico acoplado a uma esteira para auxiliar pacientes com dificuldades na marcha devido a lesões neurológicas ou outras condições motoras. O sistema Lokomat permite um treinamento intensivo e repetitivo da marcha, promovendo a recuperação da mobilidade e da função locomotora.

📌 **Game Ready System:** Sistema de compressão fria e intermitente utilizado para reduzir a dor e o inchaço após lesões ou cirurgias.

📌 **Hidroterapia:** Terapia que utiliza a água para promover a reabilitação física, aliviando a dor e melhorando a mobilidade e a força muscular. Essa prática pode ocorrer por meio de banhos terapêuticos, hidromassagem ou exercícios aquáticos, sendo também conhecida como **terapia aquática**.

📌 **Laserterapia:** Técnica que utiliza laser de baixa intensidade para promover a cicatrização, reduzir a dor e a inflamação em músculos, articulações e tecidos moles. Indicada para tratamento de lesões musculoesqueléticas, artrites, tendinites e recuperação pós-cirúrgica. Obs.: não confundir com laserterapia utilizada em outros tipos de procedimentos, como Laserterapia para mucosite oral, que pertence ao ROL e possui DUT.

📌 **Manipulação vertebral:** Técnica de fisioterapia que envolve manipulações manuais na coluna vertebral para aliviar dores e melhorar a mobilidade.

📌 **Ortotripsia/Ondas de choque:** Tratamento que utiliza ondas acústicas de alta energia para estimular a regeneração de tecidos, aliviar dores e tratar condições musculoesqueléticas como tendinites, fascite plantar e calcificações.

📌 **Pediasuit:** Terapia intensiva para crianças com distúrbios neurológicos, utilizando um traje especial para melhorar a função motora e a coordenação.

📌 **Pilates:** Método de exercício físico que fortalece os músculos, melhora a flexibilidade e a postura, utilizando movimentos controlados e respiração.

📌 **Quiropraxia:** é uma prática da medicina alternativa que se concentra no diagnóstico, tratamento e prevenção de problemas do sistema neuro-músculo-esquelético, principalmente relacionados à coluna vertebral. Utiliza técnicas manuais, como ajustes vertebrais, para restaurar o alinhamento e a função adequados da coluna e de outras articulações

📌 **TECAR:** Terapia que utiliza correntes elétricas de alta frequência para promover a regeneração dos tecidos e alívio da dor.

📌 **Terapia Therasuit:** Terapia intensiva que utiliza um traje especial para melhorar a força muscular, a coordenação e a mobilidade em pacientes com distúrbios neurológicos.

📌 **Theratogs:** Sistema de vestuário terapêutico que melhora a postura e a função motora em pacientes com distúrbios neuromotores.

Técnicas com observações especiais

⚠️ Se houver cobrança de materiais ou taxas relacionadas ao atendimento, encaminhar à consultoria para avaliação. Não somar à sessão.

📌**Agulhamento a seco vs. Acupuntura:** São procedimentos distintos, com códigos diferentes.

- **Agulhamento a seco** (código TUSS 20103301) é uma técnica fisioterapêutica que utiliza agulhas sólidas para atingir pontos gatilho miofasciais, com o objetivo de reduzir dor e melhorar função muscular. Atua sobre estruturas musculares e fasciais, sem relação com meridianos ou conceitos energéticos. **Não utiliza qualquer tipo de medicamento ou substância injetável**, diferindo de infiltrações, que envolvem fármacos.
    - Agulhamento só pode ser feito por médico fisiatra. **Fisioterapeuta não pode realizar agulhamento a seco**.
- **Acupuntura** (código TUSS 31601014) é uma prática da Medicina Tradicional Chinesa que consiste na inserção de agulhas em pontos específicos ao longo dos meridianos, visando equilibrar a energia vital (Qi) e tratar diversas condições físicas e emocionais, segundo princípios orientais.
    - Já a acupuntura pode ser liberada para fisioterapeuta.

📌 **Bobath:** Liberar conforme patologia. Normalmente o quadro é retardo do desenvolvimento psicomotor (20103689), mas avaliar conforme o caso.

Quando realizado pelo psicólogo, terapeuta ocupacional ou fonoaudiólogo, caso haja cobertura contratual para essas terapias, pagaremos de acordo com o código relacionado ao profissional que efetuou o atendimento.

Em caso de cobrança com valor abusivo e/ou com várias sessões por dia, considerar o uso da "***A200 – terapia multidisciplinar***" ou "***A200 A - ficha de frequência terapias***", caso não haja todas as informações necessárias (aguardar uma ou outra, pois a ficha de frequência já é solicitada na A200!).

📌 **Cinesioterapia específica:** Método de fisioterapia que utiliza movimentos e exercícios terapêuticos para reabilitar e fortalecer músculos e articulações, melhorando a mobilidade e a função corporal. Indicada para reabilitação pós-cirúrgica, tratamento de lesões e condições crônicas. **Não é uma técnica isolada**, e sim uma abordagem terapêutica dentro da fisioterapia, que engloba técnicas que fazem uso do movimento para reabilitação funcional.

Embora não faça parte do rol obrigatório, é divulgada ao segurado em nossa tabela de reembolso. Além disso, conforme entendimento da ANS, a cinesioterapia é passível de negativa apenas quando se trata de técnica específica, como RPG ou Pilates, que são cinesioterápicas. Sendo assim, quando a descrição for genérica não é possível negar.

Apesar das regras dispostas a seguir, pode haver casos em que o código 20103115 é o mais aplicável a determinado quadro clínico ou conduta cinesioterápica, então o uso não é necessariamente vedado. Todavia, seguem as definições:

✅ Para casos sem suspeitas de fraude:

- Liberar conforme a patologia sem solicitar complemento questionando a técnica específica.
- **Já se descrito a técnica Pilates, negar**. Quanto ao RPG, liberamos para a maioria das apólices, a não ser as que tem exclusão.

⚠️ Para casos suspeitos de fraude:

- Se cobrado código 20103115 ("Atividade reflexa ou aplicação de técnica cinesioterápica específica"), negar.
- Se cobrado apenas cinesioterapia sem menção a técnica, aguardar **A107/A170** (avaliar o uso de cada!).

📌 **Crioterapia:** Utiliza a aplicação de frio, como gelo ou dispositivos de resfriamento, para reduzir inflamação, inchaço e dor em lesões musculoesqueléticas agudas. Promove vasoconstrição, diminui metabolismo celular e alivia a dor. Para entorses, distensões e contusões.

- Liberamos conforme patologia. No entanto, se houver cobrança do código 20104073 (CRIOTERAPIA [GRUPO DE ATÉ 5 LESOES]), negar com carta diferenciada **N305**: O código 20104073 se refere a crioterapia para lesões dermatológicas e, portanto, não é compatível com procedimento fisioterápico.

📌 **Drenagem linfática:** é uma técnica de massagem que visa estimular o sistema linfático, responsável por remover fluidos e toxinas do corpo. Através de movimentos suaves e rítmicos, a drenagem linfática ajuda a promover a circulação da linfa, um líquido que transporta resíduos e células de defesa, auxiliando na redução de inchaços, na eliminação de toxinas e na melhora da circulação.

- Podemos liberar desde que a indicação não esteja relacionada a estética e seja aplicada por médico fisiatra ou fisioterapeuta. Procedimentos destinados exclusivamente à redução de medidas, celulite, modelagem corporal ou melhora estética da pele são considerados estéticos. Já procedimentos voltados ao tratamento de linfedema, edemas pós-cirúrgicos, fibrose, cicatrizes patológicas, insuficiências circulatórias ou alterações cutâneas de origem clínica são terapêuticos e passíveis de reembolso**.** Código 20103212 - DISTURBIOS CIRCULATÓRIOS ARTERIO-VENOSOS E LINFÁTICOS. Se estético (em caso de dúvida, avaliar junto à consultoria/coordenação), negar com N236.

- ⚠️ Quanto à drenagem para **LIPEDEMA:**
  - Lipedema é uma doença crônica e progressiva caracterizada pelo acúmulo anormal e simétrico de tecido adiposo subcutâneo, predominantemente nos membros inferiores (coxas, pernas, quadris e tornozelos), poupando os pés.
  - Para cobrança de fisioterapia para lipedema em região de MMII e MMSS ou de região abdominal, aguardar a carta diferenciada:
    - Solicitamos relatório médico com descrição completa da sintomatologia, exame físico, programação terapêutica, técnica utilizada para as sessões de fisioterapia, além de laudo de ultrassom, ressonância ou linfocintilografia.

📌 **Fisioterapia dermato-funcional:** A fisioterapia dermato-funcional é uma especialidade voltada para prevenção e tratamento de alterações funcionais do sistema tegumentar (pele e tecidos subcutâneos), geralmente relacionadas a processos estéticos ou reparadores. Atua em condições como cicatrizes, edemas, fibroses, celulite, flacidez e pós-operatórios, utilizando recursos como drenagem linfática, eletroterapia, ultrassom terapêutico e técnicas manuais.

- Será analisado caso a caso, considerando a existência de patologia e alteração funcional do sistema tegumentar. Para avaliação da cobertura, é indispensável relatório médico detalhado contendo diagnóstico, indicação clínica e técnicas

propostas. **Havendo patologia de fato**, a liberação deverá seguir o código correspondente ao distúrbio circulatório linfático, 20103212.
- Assim como explicado no item Drenagem Linfática, deve ser observado se a indicação para dermato-funcional não é estética.

📌 **Microfisioterapia:** técnica manual criada na França nos anos 1980 que busca identificar e tratar a causa primária de doenças ou disfunções por meio de micropalpações sutis no corpo. Baseia-se em princípios de embriologia e fisiologia, considerando que o organismo guarda memórias de traumas físicos, emocionais ou químicos que afetam sua vitalidade. Ao localizar essas áreas, o terapeuta estimula mecanismos naturais de autocorreção e autorregulação para restaurar o equilíbrio e a saúde.

- A cobertura de fisioterapia está vinculada à patologia física. O rol da ANS prevê cobertura apenas para reeducação ou reabilitação funcional de patologias físicas, não incluindo condições emocionais ou transtornos mentais. ⚠️ Atenção: quando indicada para dor física, como **fibromialgia**, devemos liberar conforme código estipulado para a patologia. Para demais casos, negar com **N433 – FISIOTERAPIA P/ TRANSTORNOS MENTAIS**. Não há necessidade de tecnologia diferenciada, pois trata-se apenas de manipulação do paciente.

📌 **Miofibrólise percutânea/ Fibrólise/ Crochetagem mioaponeurótica:**
Usa instrumentos específicos que permitem ao fisioterapeuta acessar áreas profundas do tecido muscular sem causar lesões. Indicações: tratar fibrose e contraturas funcionais do tecido muscular que limitam movimento e causam dor. Liberar conforme patologia.

📌 **Osteopatia:** abordagem terapêutica manual que atua sobre o sistema musculoesquelético, visceral e craniossacral, visando restaurar a mobilidade dos tecidos e o equilíbrio funcional do corpo. Baseia-se nos princípios da anatomia e fisiologia, estimulando a autorregulação e a capacidade natural de cura sem uso de fármacos. As técnicas incluem manipulações articulares, mobilizações, liberação miofascial e ajustes posturais, aplicadas de forma individualizada.

- A partir de eventos realizados em 23/6/21, conforme alinhado com Normas e Procedimentos, passaremos a liberar a osteopatia desde que: solicitado por médico e para patologias cobertas, realizado por fisioterapeuta ou médico fisiatra e em estabelecimento de saúde.

Técnicas que caracterizam osteopatia:
- Terapia craniossacral
- Liberação miofascial
- Liberação visceral
- Mobilização do diafragma e estruturas torácicas
- Estimulação neuromuscular para normalização do tônus do esfíncter esofagiano inferior

📢 A liberação é **conforme patologia** constante no pedido, exceto para o estipulado a seguir:
Para quadros funcionais **sem código específico** (ex.: refluxo, cólica, constipação etc.), tanto em **bebês quanto adultos**, normatizamos a liberação pelo código 50000160, considerando que a intervenção se caracteriza como atendimento fisioterapêutico voltado ao sistema músculo-esquelético. A osteopatia utiliza técnicas manuais sobre estruturas músculo-esqueléticas e fasciais, com objetivo de melhorar mobilidade e função visceral.

Segue abaixo a lista de indicações comuns, separadas por dois tipos de liberação.

Atenção para fisioterapia domiciliar, que é muito comum para bebês!

Para os quadros a seguir, liberar conforme 50000160 - ATENDIMENTO FISIOTERAPEUTICO AMBULATORIAL AO PACIENTE COM DISFUNCAO DECORRENTE DE ALTERACOES DO SISTEMA MUSCULO-ESQUELETICO.

- Alterações funcionais musculoesqueléticas inespecíficas
- Refluxo gastroesofágico
- Cólica infantil
- Constipação e disquesia
- Distúrbios do sono
- Obstrução do canal lacrimal
- Irritabilidade e choro excessivo
- Dificuldades de amamentação

Para os quadros a seguir, liberar conforme código próprio:

- Assimetrias cranianas (plagiocefalia, braquicefalia) - 20103654
- Torcicolo congênito - 20103506

📌 **Terapia Manual:** termo genérico que engloba várias técnicas realizadas com as mãos para tratar disfunções musculoesqueléticas (mobilizações, manipulações, liberação miofascial, drenagem linfática etc.). Liberar conforme patologia.

📌 **Terapia MIG e Terapia Treini:**

- **MIG:** Metodologia interdisciplinar criada pelo fisioterapeuta Renato Loffi em 2017, que inclui o uso de um exoesqueleto flexível e técnicas manuais para crianças com TEA, promovendo habilidades sociais, motoras e sensoriais.

- **Treini:** método intensivo de reabilitação neurológica baseado na neuroplasticidade, que combina exercícios funcionais, estímulos sensoriais e uso de exoesqueletos flexíveis. O objetivo é melhorar postura, mobilidade e independência em pacientes com disfunções neuropsicomotoras. É aplicada

por equipe multidisciplinar em ambiente enriquecido, com alta carga terapêutica.

➡️ Para estas duas terapias:

Nos planos não adaptados, negamos como fora da tabela.

Solicitações do Estado de São Paulo – Negar **N213** para solicitações a partir de 11 de julho de 2024.
Conforme parecer do CREMESP emitido em 11/07/2024, em resposta à Consulta de nº 98.295/24, foi definido tratar-se de método experimental, portanto não contemplado pelo ROL vigente em seu artigo 10, inciso I.

Nos casos de reclamação, informaremos ao segurado o motivo da negativa e o que diz o parecer.
Solicitações provenientes de **outros locais** que não São Paulo, favor dividir com consultor/gerência.

📌 **Terapia por contensão induzida:** A TCI é uma abordagem neurofuncional utilizada na reabilitação motora, especialmente para pacientes com hemiparesia ou outras condições neurológicas que afetam o movimento de um dos membros superiores. Seu objetivo principal é aumentar o uso funcional do membro acometido, combatendo o fenômeno do "não-uso aprendido" e promovendo reorganização cortical uso-dependente.
A técnica é baseada na restrição do membro não acometido com uso de dispositivos (como luvas ou gesso) para limitar o membro saudável em 90% do tempo acordado.

Liberar conforme a patologia. Não liberar o gesso ou luva, pois a imobilização está vinculada a procedimentos cirúrgicos e invasivos, portanto, sem cobertura para reabilitação.

R.P.G - Reeducação Postural Global

Criado por Philippe Souchard, a **Reeducação Postural Global (RPG)** é um método fisioterapêutico baseado em alongamentos ativos e globais, realizados de forma lenta e progressiva, com controle respiratório e consciência corporal. O objetivo é **corrigir desequilíbrios musculares, melhorar o alinhamento postural e reduzir sobrecarga mecânica**, atuando sobre cadeias musculares interligadas.

Como funciona:

- O paciente é colocado em posturas específicas que alongam cadeias musculares encurtadas.
- Cada postura é mantida por períodos prolongados, com ajustes manuais do fisioterapeuta.
- O trabalho é associado à respiração diafragmática, para reduzir tensão e melhorar expansibilidade torácica.
- O método busca reorganizar a postura global, não apenas tratar sintomas locais.

É indicada para alterações posturais (escoliose, hiperlordose, hipercifose, retificação da coluna), dores musculoesqueléticas (lombalgia, cervicalgia, dorsalgia, dor ciática), disfunções articulares (hérnia, protrusão discal, síndromes musculotendíneas (LER/DORT), distúrbios respiratórios (para melhora da expansibilidade torácica) e disfunções temporomandibulares.



✅ Embora seja um procedimento ROL NÃO, ele está como DIVULGA SIM [site/rede] na tabela de reembolso, portanto podemos liberar nas apólices adaptadas com o código TUSS 50000446, e nas não adaptadas com o código THSM 25100076, se houver aditivo de fisioterapia por doença (compreensiva/ampliação de coberturas/GLOBAL).
Para mais detalhes das regras de liberação, verificar seção Pedido Médico x Cobrança.

ATENÇÃO!

Nas apólices com modalidade de **REEMBOLSO COMPLETO, em que não haja contratação de pacotes extra-ROL, não há cobertura para procedimentos ROL NÃO,** mesmo que constem na tabela de reembolso e sejam divulga sim. Este é o caso do RPG, portanto, **não há cobertura contratual para este tipo de apólice.**
O comportamento do SCAM é zerar a despesa ao codificar e incluir crítica: "*Apólice sem cobertura para o procedimento*". O analista deve adicionar a crítica N205, para melhor entendimento do segurado.

Há estipulantes que retiraram para planos selecionados cobertura para determinados procedimentos, por exemplo, EXAMES SIMPLES e RPG. Sendo assim, do mesmo modo que o REEMBOLSO COMPLETO, para essas empresas o SCAM apresenta valor zerado na aba Cálculo quando codificamos a despesa.
Na aba crítica, é gerada a seguinte crítica restritiva, **que não deve ser liberada, e sim mantida pelo analista**: "*Apólice não prevê reembolso para o procedimento em questão*".
Esse tipo de comunicação sistêmica também pode ser observado na aba CBTI do SCAM Reembolso.

Estimulação Elétrica Transcutânea (TENS)



A **Estimulação Elétrica Transcutânea (EET**), também conhecida como TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation), é uma técnica terapêutica que utiliza corrente elétrica de baixa voltagem para aliviar a dor. Essa corrente é aplicada na pele através de eletrodos, com o objetivo de estimular os nervos periféricos e modular a percepção da dor.

Orientações Gerais

✅ Técnicas como Corrente russa e Estimulação Elétrica Funcional (FES) também são consideradas formas de TENS. No entanto, a corrente russa tem foco em fortalecimento muscular, o que está fora da DUT. Avaliar o pedido médico e relatório do prestador.

✅ A análise é do **RSMH**.

✅ Código 31602185 (TUSS [pós-lei e pré-lei adaptada) e 16010175 (THSM [pré-lei])



✅ **Nas apólices anteriores a lei**, com ou sem aditivos (ampliação de cobertura e/ou compreensiva), não vamos liberar o código da THSM específico da Estimulação Elétrica Transcutânea (TENS) para casos novos. **Vamos pagar conforme patologia constante no pedido do médico assistente**, utilizando os códigos da TSHM, pois entendemos que o código de TENS constante na THSM faz referência à classe de anestesia e não de reabilitação física. Esse posicionamento é defensável nos canais de manifestação. Todavia, se já estamos liberando o código, vamos mantê-lo.
Lembrando que para pré-lei não podemos falar em ROL e nem seguir diretriz de utilização.

✅ A liberação do TENS para pré-lei deve seguir o contrato: se não há aditivos, há cobertura somente para indicação por **trauma**. Para doença, apenas se foi contratada compreensiva ou ampliação de cobertura.

✅ Para negativa por desacordo com a DUT 24, a indicação do procedimento não pode constar nos critérios do GRUPO II (ver página seguinte). Um ponto crucial da análise é identificar as regiões corporais acometidas pela patologia e, principalmente, a aplicação do TENS.
Exemplo: há exclusão quando a aplicação ocorre na parte anterior do pescoço, na região da cabeça (quando posicionada de forma transcerebral) ou próxima à boca e aos olhos. Por isso, indicações como cervicalgia e disfunções da articulação temporomandibular exigem atenção especial à diretriz e podem justificar uma negativa — sempre avaliar caso a caso.

✅ **Para apólices adaptadas a lei** e da segmentação ambulatorial, a cobertura está condicionada a **Diretriz de Utilização nº24** da RN465 da ANS disposta no ANEXO II**.** O analista deve avaliar a indicação do médico assistente e comparar com os critérios da DUT; se houver elemento de exclusão, negaremos com a crítica **N294**. Se houver cobertura, vamos liberar com o **código TUSS 31602185** caso a técnica conste no pedido médico (mais informações sobre técnica x pedido médico veremos a seguir).

Entendendo a Diretriz 24

A DUT 24 estabelece que a TENS deve ser coberta quando **há pelo menos um critério do Grupo I** e **nenhum do Grupo II**. Esses critérios são:

Grupo I - Indicações para cobertura obrigatória:

a) **Dor neurogênica**
   - **O que é:** Dor originada por lesão ou disfunção do sistema nervoso (ex.: neuropatia periférica, radiculopatia).
   - **Justificativa:** Atua modulando a transmissão nociceptiva via teoria do "Gate Control" e liberação de endorfinas, reduzindo a percepção da dor.

b) **Dor musculoesquelética**
   - **O que é:** Dor em músculos, articulações, tendões ou ligamentos (ex.: lombalgia, cervicalgia).
   - **Justificativa:** TENS é amplamente utilizada para analgesia em condições musculoesqueléticas, com evidência de eficácia para dor aguda e crônica.

c) **Dor visceral**
   - **O que é:** Dor proveniente de órgãos internos (ex.: cólica renal, dor abdominal funcional).
   - **Justificativa:** Estímulo elétrico pode reduzir a transmissão dos sinais de dor vindos dos órgãos internos, embora protocolos sejam mais restritos.

d) **Dor simpaticamente mediada**
   - **O que é:** Dor associada à hiperatividade do sistema nervoso simpático (ex.: síndrome dolorosa regional complexa).
   - **Justificativa:** TENS pode ajudar a modular reflexos simpáticos e reduzir dor.

e) **Dor pós-traumática**
   - **O que é:** Dor após lesão física (ex.: fraturas, entorses).
   - **Justificativa:** Evidência suporta uso para analgesia e melhora funcional no processo de reabilitação.

f) **Dor leve a moderada pós-operatória**
   - **O que é:** Dor após procedimentos cirúrgicos, geralmente em fase inicial de recuperação.
   - **Justificativa:** TENS é recurso não farmacológico para controle da dor pós-operatória, reduzindo necessidade de analgésicos.

g) **Espasticidade da lesão medular e hemiplegia decorrente de AVE**
   - **O que é:** Aumento do tônus muscular após lesão medular ou acidente vascular encefálico.
   - **Justificativa:** TENS pode auxiliar na redução da espasticidade, embora protocolos variem; por isso está incluída como indicação



Grupo II – Situações que excluem cobertura:



a) Gestação – 1º trimestre

- Durante a organogênese, qualquer estímulo elétrico próximo ao útero pode teoricamente induzir contrações ou alterar desenvolvimento fetal.
  Não há estudos que comprovem segurança, por isso a exclusão é preventiva.

b) Uso para melhora do equilíbrio no AVE crônico

- TENS atua na modulação da dor, não no controle motor ou equilíbrio. Evidências para essa aplicação são inconsistentes e não padronizadas, logo não há benefício comprovado.

c) Pacientes portadores de:

- **Marcapasso cardíaco:** Correntes elétricas externas podem interferir no funcionamento do dispositivo, causando falhas ou arritmias.
- **Arritmias cardíacas (salvo ordem médica):** Estímulo próximo ao pescoço ou tórax pode ativar reflexos vagais, alterando frequência cardíaca.
- **Dor de etiologia desconhecida:** TENS pode mascarar sintomas, atrasando diagnóstico de condições graves.
- **Epilepsia (salvo ordem médica):** Estímulo craniano pode reduzir limiar convulsivo, aumentando risco de crises.

d) Regiões proibidas:

- **Parte anterior do pescoço / seio carotídeo:** Estímulo pode ativar barorreceptores, causando bradicardia, hipotensão ou síncope.
- **Cabeça (transcerebral):** Corrente atravessando o crânio pode afetar estruturas neurológicas e aumentar risco de convulsão.
- **Pele com solução de continuidade (ferida, dermatite):** Redução da resistência elétrica → risco de queimadura, irritação e infecção.
- **Pele com parestesia/anestesia:** Paciente não percebe intensidade excessiva → risco de lesão térmica.
- **Abdome durante gestação:** Desconhece-se o efeito seguro da corrente sobre o útero; risco teórico de contrações; recomenda-se evitar.
- **Regiões com implantes metálicos:** Possível concentração de corrente e aquecimento local; embora risco seja baixo, exclusão é preventiva.
- **Áreas recentemente irradiadas:** Tecido fragilizado, com resposta inflamatória alterada → maior risco de lesão.
- **Próximo à boca e sobre os olhos:** Tecidos sensíveis, sem indicação terapêutica, risco de dano ocular ou mucoso.

Sobre o item de exclusão *"regiões com implantes metálicos"*, *do GRUPO II, letra [d]:* é importante consultar se existe procedimento cirúrgico no histórico da apólice (SISB/Grande Porte/SCAM), buscando nas senhas, boletins operatórios e relatórios informações sobre os materiais utilizados no procedimento, como por exemplo, placas, parafusos etc. Se houver confirmação de implante metálico e o TENS está sendo aplicado na mesma região, vamos negar com **N294** sem solicitação de complemento. Esta avaliação deve ser feita junto ao consultor, a fim de confirmar se o material realmente é metálico e está implantado na região estimulada.

Se restar dúvida sobre a composição do material utilizado ou não houver informações suficientes, solicitar relatório pedindo esclarecimentos adicionais sobre a cirurgia e/ou material utilizado.

⚠️ Atenção: sempre informar a pesquisa em nota!

❗ Cirurgias com alta chance de implantes metálicos

Se houver histórico dessas cirurgias, **presumir metal**.

➡️ **Artroplastia coxo-femoral (quadril)**
Substituição da articulação do quadril por uma prótese metálica (componente femoral e acetabular), geralmente por desgaste ou fratura.

➡️ **Artroplastia de joelho**
Troca da articulação do joelho por prótese metálica, comum em casos de artrose avançada.

➡️ **Artrodese de coluna**
Fixação cirúrgica de vértebras com hastes, placas e parafusos metálicos para estabilizar a coluna (ex.: escoliose, fraturas).

➡️ **Osteossíntese / fraturas graves (ex.: fratura exposta) com fixação interna**
Técnica para unir fragmentos ósseos após fratura usando placas, parafusos ou hastes intramedulares.

➡️ **Osteotomias corretivas**
Cirurgia para correção de desalinhamento ósseo, geralmente com placas e parafusos metálicos.

🔔 Cirurgias que merecem atenção (podem ter implantes metálicos):

➡️ **Cirurgias de ombro**
Podem envolver artroplastia ou reparo com âncoras (metálicas ou bioabsorvíveis) para fixar tendões.

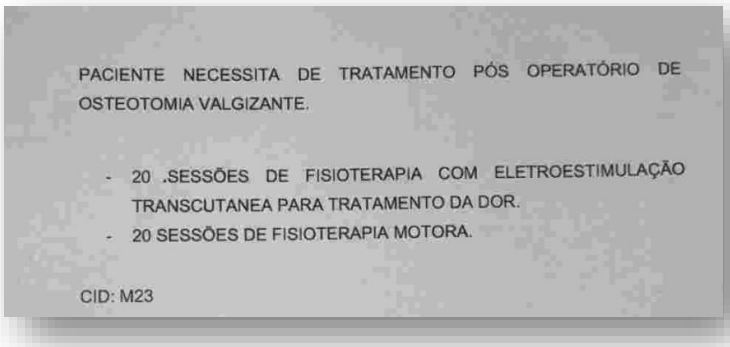
➡️ **Cirurgias de tornozelo ou pé**
Correção de fraturas ou deformidades com placas e parafusos, dependendo da gravidade.

➡️ **Reconstruções ósseas complexas**
Realizadas após tumores ou grandes perdas ósseas, geralmente com placas ou sistemas metálicos.

🎯 **Neste exemplo, uma cobrança de TENS com indicação de pós-operatório de osteotomia valgizante**, para corrigir joelho varo (pernas arqueadas). O objetivo é reposicionar o osso para melhorar o alinhamento e a distribuição do peso, aliviando a dor e melhorando a função. Existem diferentes tipos de osteotomia valgizante, dependendo da localização do desalinhamento (joelho, quadril, tornozelo) e da técnica cirúrgica utilizada.

GI CIRURGICA 10/12/2024 12:05 JA[redacted] Lib 69746776 113396505




PACIENTE NECESSITA DE TRATAMENTO PÓS OPERATÓRIO DE OSTEOTOMIA VALGIZANTE.

- 20 .SESSÕES DE FISIOTERAPIA COM ELETROESTIMULAÇÃO TRANSCUTANEA PARA TRATAMENTO DA DOR.
- 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA.

CID: M23

Entre as documentações, foi apresentada a imagem de implante metálico no joelho

Neste outro exemplo, constava na descrição cirúrgica a informação de: **PLACA TIBIA PROXIMAL + 2 PARAFUSOS CANULADOS MAXCARE;**
O paciente acabou sofrendo um trauma no joelho após uma queda.

Tipo solicitação: Internação
Tipo de vaga: Cirúrgica
Acomodação desejada: Apartamento Hospital
Convênio: BRADESCO OPERAD
Convênio: COLETIVO/EMPRESARIAL
Plano: Nacional Flex
Quarto privativo: Não
Médico: Ricardo Fontes Lavieri
Hipótese diagnóstica: PACIENTE VÍTIMA DE QUEDA AO SOLO COM TRAUMA NO JOELHO ESQ. APRSENTA FRATURA DESVIADA DO PLANALTO TIBIAL COM AFUNDAMENTO. NECESSITA REDUÇÃO E FIXAÇÃO INTERNA.
Clínica: Ortopédica
CID: S821 - FRATURA DA EXTREMIDADE PROXIMAL DA TIBIA
Necessita diálise: Não
Necessita isolamento: Não
Previsão OPME: Não
Em quimioterapia: Não
Observação: PLACA TIBIA PROXIMAL + 2 PARAFUSOS CANULADOSMAXCARE
Procedimentos adicionais: Fraturas E/Ou Luxações Ao Nível Do Joelho - Tratamento Cirúrgico

Ricardo Fontes Lavieri
CRM 77198

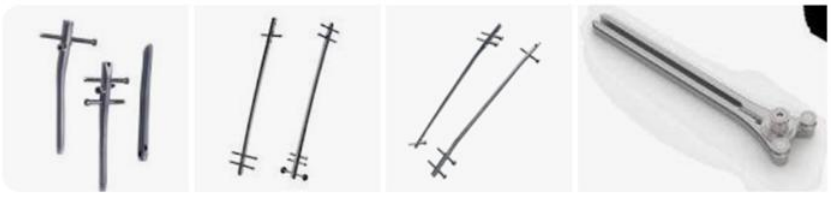
Tibia proximal

Especificações

- Placa bloqueada em Aço.
- Bloqueios diafisários poliaxiais com até 30° de angulação alternados com corticais.
- Formato anatômico.
- Parafusos bloqueados de 4.0 mm de diâmetro nos tamanhos de 14 à 95mm.
- Parafusos corticais de 3.5 mm de diâmetro nos tamanhos de 14 à 95mm.
- Parafusos esponjosos de 4.0 mm de diâmetro nos tamanhos de 14 à 95mm.



Imagens de parafusos canulados maxcare



PEDIDO MÉDICO X COBRANÇA

Existem algumas situações envolvendo o pedido médico e as cobranças feitas pelos prestadores. **As ações detalhadas a seguir são para dois cenários que devem ser bem diferenciados pela equipe de análise: cobranças normais e cobranças abusivas**.

O escopo abordado nesta seção refere-se a divergências entre o pedido médico e cobrança do prestador, referente às técnicas com código próprio: RPG, biofeedback, TENS, eletroestimulação para assoalho pélvico.

Todavia, a fim de completar o entendimento, adiantaremos o tema "codificação", descrevendo a seguir as condutas referentes a **cobranças concomitantes** de técnica (com código próprio na tabela) e fisioterapia convencional (código de patologia, região anatômica etc.).

Válido para casos novos, ou que não haja pagamento anterior divergente nos códigos. Portanto, muita atenção ao histórico!

Observação 1: O analista deve avaliar o relatório do prestador, a fim de identificar se a técnica cobrada de forma apartada realmente foi realizada. Em caso de dúvidas, verificar com a liderança/consultoria. Caso não tenha sido realmente realizada, cabe negativa **N305**: *Conforme relatório do prestador do serviço, a técnica XXXXXX cobrada não foi realizada.*

Observação 2: A liberação só deverá ocorrer se atendidos os critérios estabelecidos (pedido vs. cobrança).

- Cobranças em único recibo:
  - **Biofeedback + eletroestimulação de assoalho + fisio convencional** = liberar somente biofeedback + eletroestimulação, somando o valor da fisio.
  - **Biofeedback + fisio convencional** = somar os valores e liberar somente o código de biofeedback.
  - **Eletroestimulação de assoalho + fisio convencional** = somar os valores e liberar somente o código de eletroestimulação.
  - **Biofeedback + eletroestimulação de assoalho** = liberar os dois.
  - **Estimulação Elétrica Transcutânea (TENS) + fisio convencional** = liberar os dois.
  - **RPG + fisio convencional** = liberar os dois.

- Cobrança em recibos diferentes:
  - Não podemos negar a fisioterapia convencional. Liberar individualmente.

📌 Leia sobre estas terapias neste manual para se informar de todos os detalhes!

➡️ A seguir, os cenários de Pedido vs. Cobrança.



1) Cenário 1: cobrança normal sem suspeitas de abuso: fisioterapia + RPG OU TENS OU eletroestimulação OU biofeedback (um ou outro!), ou seja, sem cobrança de vários códigos concomitantemente.

❖ Para recibo único:

a) Prestador cobrou fisioterapia + técnica específica, **com valores discriminados para cada**. Médico não pediu técnica, apenas "fisioterapia".
Ação: solicitar novo relatório médico indicando a técnica cobrada, **A206 A - indicação para a técnica**.
- Se não houver retorno esperado, somar e pagar somente conforme patologia do pedido inicial. **Não aguardar reiteradas vezes.**
- Se for enviada a indicação para a técnica, liberar código de fisio convencional (se aplicável, ver início desta seção!) + código da técnica individualmente.

c) Prestador cobrou fisio + técnica **sem discriminar valores**, e médico não pediu técnica (somente "fisioterapia").
Ação: solicitar valores das técnicas (**A170**) e novo pedido médico (**A206 A**).
- Se enviados os dois, liberar os dois códigos individualmente (se aplicável, ver início desta seção!).
- Se em complemento não for enviado nenhum dos dois, somar valores e pagar conforme patologia do pedido inicial. **Não aguardar reiteradas vezes**.
- Se enviado apenas os valores e não enviado o novo pedido, aguardar o pedido médico novamente. Se não enviado na fase 02 de complemento, somar as cobranças e pagar conforme patologia.
- Se enviado apenas o novo pedido, reiterar os valores das cobranças. Ver letra "c" abaixo.

b) Prestador cobrou fisio + técnica **sem discriminar valores**, **e médico prescreveu os dois tipos**.
Ação: solicitar valores (**A170**).
- Se não enviado, reiterar solicitação. Considerar carta diferenciada explicando detalhadamente ao segurado o que é necessário, e que documento enviado não contém o que foi solicitado.

d) Prestador cobrou apenas fisioterapia convencional, **mas médico pediu técnica específica**.
- **Cenário 1 exemplificativo**: médico fez um único pedido para fisioterapia + RPG, mas prestador cobrou apenas fisioterapia.
  Ação: **atenção para os pontos abaixo!**
  I. É preciso ter muita cautela com cobranças separadas em sinistros diferentes, pois o prestador pode ter emitido um recibo para fisio e outro para RPG. Neste caso, vamos pagar conforme a cobrança. Verificar com atenção a apólice do segurado a fim de identificar se há mais de um recibo!
  II. Se não há cobranças separadas, liberar conforme técnica do pedido. Neste exemplo, liberaríamos conforme RPG sem solicitar complemento, mesmo que a cobrança informe fisioterapia.



- **Cenário 2 exemplificativo**: no sinistro sendo analisado consta pedido médico somente para RPG e prestador cobrou como fisioterapia.

  Ação: **atenção para os pontos abaixo!**

  I. Há a possibilidade de o médico ter emitido dois pedidos, um para RPG e outro para fisioterapia, e estarem em sinistros diferentes. Se for o caso, liberar conforme a cobrança. Atenção para o histórico!

  II. No entanto, se houver somente um pedido, liberar conforme a técnica solicitada sem solicitar complemento, mesmo a cobrança sendo fisioterapia.

❖ Para recibos separados:

a) Prestador emite 2 recibos (fisioterapia e RPG, por exemplo), **mas no pedido consta apenas fisioterapia**.

Ação: reembolsar a cobrança de fisio normal conforme patologia e solicitar **A206 A** somente para a cobrança da técnica. Não pendenciar os 2 recibos!

- Se no retorno não for enviado, negar o recibo da técnica com **N415 - técnica não solicitada.**

1) Cenário 2: cobrança abusiva, com vários códigos declarados de técnica e/ou fisioterapia convencional.

❖ Para recibo único:

a) Prestador cobrou vários códigos, **com ou sem valores discriminados para cada**. Médico não pediu técnica, apenas "fisioterapia".
Ação: somar todas as cobranças e pagar conforme patologia descrita no pedido médico.

b) Prestador cobrou vários códigos de patologia + técnica **sem discriminar valores**, **e médico prescreveu tanto fisio convencional quanto técnica** (RPG, eletroestimulação, TENS, biofeedback).
Ação: solicitar valores (**A170**).

- Além disso, é muito importante avaliar no relatório do prestador a descrição completa da conduta para confirmar se a técnica cobrada realmente foi realizada. Caso seja identificado que não foi realizada, confirmar com a consultoria e, então, negar utilizando carta diferenciada **N305**:
  Conforme relatório do prestador do serviço, a técnica XXXXXX cobrada não foi realizada.
- Se não for enviado em fase de complemento, reiterar a solicitação. Considerar carta diferenciada explicando detalhadamente ao segurado o que é necessário, e que documento enviado não contém o que foi solicitado.

c) Prestador cobrou diversos códigos de fisioterapia convencional, **mas médico pediu também técnica específica + fisio**.
Ação: somar valores e pagar conforme patologia declarada no pedido. Não liberar código de técnica, pois conforme cobrança, não foi realizada (*lembre-se que é cenário abusivo, não sendo interessante dar abertura solicitando complemento*). Atenção para códigos fora do ROL, pois devem ser negados individualmente!

❖ Para recibos separados:

a) Prestador emite mais de um recibo com códigos de fisioterapia convencional + técnica (*cenário de abuso/suspeita de fraude!*), **mas o pedido solicita apenas fisioterapia**.
Ação: pagar somente o recibo da fisioterapia convencional e negar a cobrança da técnica com **N415 - técnica não solicitada.**

🎯 *Temos defesa em âmbito de reclamação para todos estes cenários, conforme a RN 465 e Condições Gerais.*

CÓDIGOS DE FISIOTERAPIA E SUAS APLICAÇÕES

💡 **Lembre-se: senhas de internação e SADT podem ajudar a definir um código de fisioterapia.**

Os códigos de fisioterapia da tabela podem fazer referência a patologias (lesão de nervo, retardo mental, Parkinson, entre outros), a regiões corporais (coluna, membro), abordagem (reabilitação motora, respiratória, cardiovascular, neurológica). Outros se referem a técnicas específicas (como biofeedback, RPG, TENS, eletroestimulação de assoalho pélvico).



Há muitos códigos que até então não eram utilizados, mas que são aplicáveis em diversas situações. Portanto, é muito importante que todos os códigos apresentados neste manual sejam aprendidos e utilizados pelas equipes de análise.

🚨 É fundamental analisar cuidadosamente cada solicitação e liberar os procedimentos que estejam de acordo com as normas e critérios estabelecidos, sempre avaliando o histórico de pagamentos anteriores, a fim de identificar divergências de análise.

➡️ **As condutas listadas nos códigos são para fins informativos. Não significa que todas são cobertas!**

🚨 Alguns prestadores podem tentar incluir múltiplos códigos com o objetivo de aumentar a cobrança indevidamente.

✅ **Regra para liberação de códigos**

- Para regras de liberação de cobranças concomitantes referente a técnicas com código próprio (RPG, TENS, biofeedback, eletroestimulação do assoalho pélvico) + fisio convencional (ou seja, código de patologia, de região anatômica), ver a seção PEDIDO MÉDICO X COBRANÇA.
- Múltiplas cobranças de **códigos de patologia** normalmente são somadas e liberadas conforme a patologia indicada no pedido médico, sem múltiplas codificações. Entretanto, **liberação adicional** é permitida para:
  - **Abordagens motoras e respiratórias** cobradas em concomitância, quando pertinentes ao quadro clínico e somente se houver doença respiratória ativa, distinta e documentada, que exija condutas fisioterapêuticas próprias, não contempladas pelo código principal da patologia.
  - Códigos referentes a **regiões corporais diferentes e para as quais não haja código único (ex.: coluna e membro).**

Importante: Não cabe múltipla remuneração para códigos apenas de patologia sem particularidades ou sem relação direta com o quadro.
Exemplo: Paciente com tendinite no punho → código correto: **20103484**. Não liberar junto com **20103344** (miopatia) nem **20103328** (lesão de nervo periférico), pois são condições diferentes.

Ver também a seção Técnicas com observações especiais para orientação sobre outros códigos, não tratados nesta seção (ex.: cinesioterapia).

Consulta fisioterápica

TUSS 50000144 - Consulta ambulatorial em fisioterapia

Exemplos de indicação: consulta inicial ambulatorial; avaliação inicial; reavaliação

- Não possui DUT desde junho/2021.
- Deve ser utilizada para **avaliação inicial**, **reavaliações periódicas** e **elaboração do plano de tratamento**.
- **Não cabe liberação seriada**: cada consulta deve ser justificada individualmente conforme necessidade clínica.
- **Frequência recomendada:** liberar **1x por mês**.
- Caso haja cobrança superior à frequência indicada, aguardar crítica **A225**.

Crítica A225 – Consulta Fisioterapia:

Solicitamos relatório do prestador fisioterapeuta datado, assinado e carimbado, justificando a realização de consultas em frequência seriada com curto intervalo de tempo.

TUSS 50000349 - Consulta hospitalar em fisioterapia

Exemplos de indicação: avaliação inicial do paciente internado; reavaliações periódicas durante a internação; ajuste do plano terapêutico conforme evolução clínica

🎯 Este código deve ser utilizado para consultas realizadas em ambiente hospitalar, com foco na avaliação do paciente internado, definição ou ajuste do plano de tratamento e registro da evolução clínica. Assim como na consulta ambulatorial, não possui DUT desde junho/2021 e não cabe liberação seriada: cada consulta deve ser justificada individualmente conforme necessidade clínica.

Diferentemente do ambulatorial, em regime de internação a frequência tende a ser maior devido à complexidade clínica e à necessidade de ajustes dinâmicos no plano terapêutico. Podem ser necessárias consultas adicionais em casos críticos, início de ventilação mecânica, pós-operatório imediato ou intercorrências.

No entanto, se percebida cobrança em frequência não compatível com o quadro e sem justificativa clínica, aguardar **A225**.

Códigos de teleatendimento

Códigos da tabela **THSM**. Liberação para eventos a partir de 09/07/2025.

➡️ 84251212 - teleatendimento fisioterapeutico ao paciente com alteracoes do sistema musculo-esqueletico
➡️ 84251220 - teleatendimento fisioterapeutico ao paciente com alteracoes do sistema linfatico e/ou vascular periferico
➡️ 84251239 - teleatendimento fisioterapeutico ao paciente em recuperacao de tecidos
➡️ 84251247 - teleatendimento fisioterapeutico ao paciente com alteracoes do aparelho genito-urinario e reprodutor, e/ou proctologico
➡️ 84251255 - teleatendimento fisioterapeutico ao paciente com alteracoes no sistema respiratorio
➡️ 84251263 - teleatendimento fisioterapeutico ao paciente com alteracoes do sistema cardiovascular
➡️ 84251271 - teleatendimento fisioterapeutico ao paciente com disfuncao decorrente de lesao do sistema nervoso central e/ou periferico

Códigos de membro



TUSS 20103484 - Patologia osteomioarticular em um membro

Exemplos de indicação: tendinite de punho direito; bursite ombro esquerdo; bursite trocantérica quadril direito; epicondilite lateral do cotovelo

🎯 Patologia osteomioarticular refere-se a qualquer condição que acometa estruturas do sistema musculoesquelético, incluindo ossos, articulações, músculos, tendões, ligamentos e bursas, como tendinites, bursites, lesões ligamentares, artroses e fraturas. O termo "membro" abrange as regiões anatômicas dos membros superiores (ombro, braço, cotovelo, antebraço, punho e mão) e dos membros inferiores (quadril, coxa, joelho, perna, tornozelo e pé).

Aplica-se este código quando a patologia afeta apenas um membro. É importante verificar se o médico especificou a localização, como cotovelo direito, mão esquerda, tornozelo direito, membro inferior ou superior etc.
Palavras-chave a observar: unilateral, E (abreviação de esquerdo), D (abreviação de direito), lado direito ou esquerdo, MI (membro inferior) e MS (membro superior).

- Atenção: para fisioterapia em diferentes articulações em um mesmo membro e **patologias diferentes**, será liberado 2x 20103484. Exemplos:
    1. Lesão de menisco em joelho direito e artrose de tornozelo direito;
    2. Tendinite de ombro esquerdo e bursite de cotovelo esquerdo;
    3. Epicondilite lateral do cotovelo direito e tendinite de punho direito;
    4. Bursite trocantérica quadril esquerdo e tendinite de joelho esquerdo.

As condutas podem envolver exercícios terapêuticos (fortalecimento progressivo, alongamentos, exercícios proprioceptivos), recursos eletrotermofototerápicos (TENS, ultrassom terapêutico, ondas de choque), terapia manual (mobilizações articulares, liberação miofascial), reabilitação funcional (reino de marcha, treino de preensão e função manual).



TUSS 20103492 - Patologia osteomioarticular em dois ou mais membros

Exemplos de indicação: tendinite de punho direito e esquerdo; fibromialgia; gonartrose bilateral

🎯 Aplica-se este código quando a patologia afeta mais de um membro. É importante verificar se o médico especificou a localização, como cotovelo direito e esquerdo, tornozelo direito e esquerdo etc. Quanto a fibromialgia, é uma condição crônica e sistêmica que provoca dor generalizada, frequentemente envolvendo múltiplos membros.
Palavras-chave a observar: bilateral, E (abreviação de esquerdo) e D (abreviação de direito), lado direito e esquerdo, MII (membros inferiores) e MSS (membros superiores).

As condutas normalmente são as mesmas já descritas na patologia de um membro (20103484), podendo aumentar a complexidade.



TUSS 20103298 - Hipo ou agenesia de membros

Exemplos de indicação: Ausência congênita de membro superior ou inferior; hipoplasia (desenvolvimento incompleto) de braço ou perna; amputação congênita parcial

🎯 Os códigos 20103484 ou 20103492 [Patologia osteomioarticular em um membro/mais de um membro] devem ser utilizados quando existe uma alteração funcional ou estrutural adquirida em membros, como tendinite, fratura, artrose ou outras lesões localizadas. Já o código **20103298 – Hipo ou agenesia de membros** é reservado para situações em que há ausência total ou parcial do membro, geralmente de origem congênita, como agenesia (não formação) ou hipoplasia (formação incompleta).



Códigos de coluna

TUSS 20103506 - Patologia osteomioarticular em um segmento da coluna

Exemplos de indicação: lombalgia (dor lombar); cervicalgia (dor cervical); cervicobraquialgia; degeneração do disco lombar; hérnia de disco lombar; enxaqueca; cefaleia (se origem da dor for cervical), torcicolo congênito

🎯 A coluna vertebral é dividida em segmentos anatômicos, cada um com função e características próprias.

- **Cervical (C1 a C7)** – região do pescoço, responsável por mobilidade da cabeça.
- **Torácica (T1 a T12)** – região do tórax, ligada à caixa torácica.
- **Lombar (L1 a L5)** – região inferior das costas, suporte de peso.
- **Sacral (S1 a S5)** – base da coluna, articulação com pelve.

O código aplica-se a patologia que está relacionada apenas a um segmento.

- Atenção:
    - O código não vale para desvios posturais;
    - Irradiação não deve ser considerada, sendo liberado apenas como um segmento de coluna, não cabendo liberação adicional de membro. Exemplos:
        1. Hérnia de Disco Lombar com Irradiação para as Pernas
        2. Hérnia de Disco Cervical com Irradiação para os Braços
        3. Ciática
        4. Estenose Espinhal
        5. Espondilolistese
        6. Radiculopatia Cervical ou Lombar
    - Torcicolo congênito é uma deformidade postural causada por encurtamento ou fibrose do músculo esternocleidomastoideo, levando à inclinação lateral e rotação contrária da cabeça. Provoca alteração funcional e postural da coluna cervical, com restrição de mobilidade e desalinhamento vertebral. Não se enquadra como miopatia, que é uma doença primária do tecido muscular, geralmente de origem genética ou sistêmica, que afetam múltiplos músculos e apresentam alterações estruturais ou metabólicas.

As condutas podem envolver exercícios terapêuticos (estabilização segmentar, alongamentos, exercícios de controle motor, treino funcional), terapia manual (mobilizações articulares, manipulação vertebral, liberação miofascial), recursos eletrotermofototerápicos (TENS, ultrassom terapêutico, calor superficial), abordagens complementares como hidroterapia e treino proprioceptivo para estabilidade global).



TUSS 20103514 - Patologia osteomioarticular em diferentes segmentos da coluna

Exemplos de indicação: hérnia de disco cervical associada à lombalgia; cervicobraquialgia com lombalgia crônica; degeneração discal em múltiplos segmentos

🎯 Este código deve ser utilizado quando a patologia envolve mais de um segmento da coluna vertebral, com repercussão funcional significativa. Destina-se ao tratamento fisioterapêutico para redução da dor, melhora da mobilidade, correção da mecânica postural e prevenção de complicações decorrentes da sobrecarga em múltiplos segmentos.

Como já estipulado no item anterior:

- Não se aplica para desvios posturais isolados.
- Irradiação não deve ser considerada como critério para liberação adicional de membro.

As condutas envolvidas são as mesmas já descritas no código 20103506, patologia em um segmento de coluna, podendo ter complexidade maior.



TUSS 20103182 - Desvios posturais da coluna vertebral

Exemplos de indicação: cifose; lordose; escoliose

🎯 Este código deve ser utilizado quando a patologia está associada a alterações no alinhamento fisiológico da coluna vertebral, e não a uma condição localizada em um único segmento. Os desvios posturais geralmente envolvem modificações estruturais ou funcionais que afetam a postura global, podendo comprometer equilíbrio, biomecânica e distribuição de cargas.

- **Cifose** – aumento da curvatura torácica para trás.
- **Lordose** – aumento da curvatura lombar para frente.
- **Escoliose** – desvio lateral da coluna, frequentemente acompanhado de rotação das vértebras.

As condutas podem envolver Reeducação Postural Global (RPG), pilates clínico, cinesioterapia, isostretching (técnica que combina alongamento global com controle respiratório), método Klapp (exercícios em posições quadrúpedes para correção de escoliose e melhora da mobilidade vertebral).



Código de pós-operatório

TUSS 20103093 - Atendimento fisiátrico no pré e pós-operatório de pacientes para prevenção de sequelas

Exemplos de indicação: atendimento motor no pós-operatório de cirurgias ortopédicas, atendimento motor no pré e pós-cirúrgicos de outras naturezas, se aplicável

🎯 Pré-operatório em ortopedia

Não liberar o código **20103093** para atendimentos em **pré-operatório ortopédico**. A liberação deve ser conforme código da patologia, visto a ampla gama de quadros ortopédicos e a alta utilização de fisioterapia com esta indicação.

🎯 Pós-operatório em cirurgias ortopédicas

De modo geral, também priorizar a liberação **conforme o código correspondente à patologia tratada**.

Exceção:

- Quando o pedido médico ou a cobrança do prestador indicar expressamente o código **20103093**, a liberação poderá ocorrer conforme o referido código, em razão de sua nomenclatura ampla e compatível com o contexto pós-operatório.
- Caso já tenha ocorrido pagamento prévio com o código **20103093**, e a **indicação clínica permaneça inalterada**, manter o código para evitar inconsistência de análise.

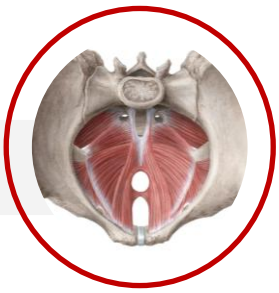
🎯 Pré e pós-operatório de cirurgias não ortopédicas

O uso do **20103093** poderá ser considerado **quando não houver outro código mais específico e apropriado disponível na tabela**, devendo a análise observar o contexto clínico e a finalidade do atendimento.

📌 **Importante:**
Se a abordagem fisioterapêutica for **predominantemente respiratória**, avaliar a utilização do código **20103069 – Assistência fisiátrica respiratória no pré e pós-operatório**.

⚠️ **Atenção:**
Considerar sempre a **possibilidade de fisioterapia domiciliar**, especialmente em pacientes com **restrição de locomoção no pós-operatório**.

bradesco saúde



Códigos de reabilitação perineal ou pré/pós-parto

TUSS 20103565 - Processos inflamatórios pélvicos

Exemplos de indicação: pubalgia (inflamação da sínfise púbica); doença inflamatória pélvica; endometrite; salpingite; ooforite; cervicite; síndrome da dor pélvica crônica inflamatória; inflamações musculotendíneas da pelve (iliopsoas, reto abdominal associadas a sobrecarga esportiva)

🎯 Este código contempla tanto processos inflamatórios pélvicos de origem visceral (ex.: DIP, salpingite, endometrite) quanto processos inflamatórios pélvicos de origem musculoesquelética, localizados na estrutura da pelve (iliopsoas, sínfise púbica).

Processos inflamatórios pélvicos referem-se a condições caracterizadas por inflamação em estruturas da pelve, que podem envolver tecidos **musculoesqueléticos** (ossos, articulações, tendões, músculos) ou **viscerais** (órgãos do trato genital e urinário). Essa inflamação pode ser decorrente de sobrecarga mecânica, infecções, traumas, cirurgias ou doenças sistêmicas, gerando dor, limitação funcional e alterações posturais.

A fisioterapia tem como objetivo reduzir dor, restaurar mobilidade tecidual, prevenir aderências e melhorar a função das estruturas acometidas. A abordagem geralmente combina técnicas manuais suaves, alongamento direcionado, fortalecimento progressivo, recursos analgésicos não-invasivos.

TUSS 20103190 - Disfunção vesico-uretral

Exemplos de indicação: incontinência urinária (esforço, urgência, mista); urgência miccional / bexiga hiperativa; retenção urinária funcional; disfunção miccional por dissinergia do assoalho pélvico; sintomas urinários pós-cirurgia pélvica (quando abordagem conservadora é indicada); reabilitação pós-prostatectomia

🎯 Disfunção vesico-uretral refere-se a alterações funcionais no trato urinário inferior, envolvendo a bexiga (vesical) e/ou a uretra, que comprometem a coordenação entre armazenamento e eliminação da urina. Essas disfunções podem se manifestar por sintomas como:



- **Incontinência urinária** (esforço, urgência ou mista)
- **Urgência miccional** e aumento da frequência urinária
- **Retenção urinária** ou esvaziamento incompleto
- **Infecções urinárias recorrentes** associadas à disfunção
- **Dificuldade de iniciar ou manter o fluxo urinário** (disfunção miccional/dissinergia)

A abordagem de primeira linha é o PFMT/TMAP (Treinamento Muscular do Assoalho Pélvico), que consiste em **exercícios voluntários** para contração e relaxamento dos músculos do assoalho pélvico, realizados em diferentes posições, com progressão de séries e monitoramento pelo fisioterapeuta.

Termos como “Exercícios de Kegel”, “Exercícios do Assoalho Pélvico” ou “Fisioterapia pélvica” equivalem a PFMT e devem ser liberados pelo código 20103190. Também liberar quando o pedido médico indicar fisioterapia para disfunções urinárias (IU, urgência, retenção etc.), sem técnica específica descrita.

O código 20103190 não é aplicável a incontinência fecal, constipação, vaginismo, dispaurenia, hipotonia/hipertonia pélvica sem sintomas urinários. Considerar os códigos 20203020 ou 20103646, a depender do que foi realizado.



TUSS 20203020 - Eletroestimulação do assoalho pélvico e/ou outra técnica de exercícios perineais

Exemplos de indicação: incontinência urinária (esforço, urgência, mista); incontinência fecal (urgência/passiva); bexiga hiperativa (urgência miccional); dispareunia; retenção urinária por falha de contração; disfunção miccional por dissinergia pélvica; hipotonia do assoalho; vaginismo; hipertonia perineal; constipação funcional por anismo/dissinergia anorretal

🎯 A eletroestimulação do assoalho pélvico é uma técnica usada para ativar ou modular a musculatura perineal por meio de impulsos elétricos controlados. É geralmente feita por **sonda** intravaginal (mulheres) ou sonda anal (homens ou casos de incontinência fecal). Existem também eletrodos superficiais (perineais) ou sistemas magnéticos, mas os mais comuns são internos.

Para as incontinências, o treinamento dos músculos do assoalho pélvico (PFMT) é primeira linha; a eletroestimulação pode ser considerada como adjuvante ou ponte para quem não consegue contrair voluntariamente ou quando se busca modular sintomas urinários/anais.

Este código refere-se predominantemente à eletroestimulação intracavitária (intravaginal ou intra-anal) com objetivo de atingir o assoalho pélvico. Não é considerada terapia de primeira linha durante a gestação, devendo ser priorizado, sempre que possível, o treinamento muscular voluntário do assoalho pélvico. Entretanto, a gestação não constitui contraindicação absoluta, pois o procedimento pode ser considerado de forma criteriosa e individualizada, especialmente em gestantes que apresentem dificuldade ou incapacidade de realizar a contração voluntária eficaz da musculatura do assoalho pélvico.
Todavia, devem ser respeitadas as contraindicações: gestação de alto risco, sangramento vaginal sem etiologia definida, ameaça de parto prematuro, infecções ativas e dor pélvica sem diagnóstico esclarecido.
Caso haja alguma destas contraindicações, ao tempo que foi prescrita a eletroestimulação, levar o caso à Consultoria.

Se cobrado TENS (31602185), deve ser observada a DUT que prevê exclusão para gestantes em algumas situações. O TENS é uma técnica analgésica superficial, aplicada com eletrodos na pele, indicada para controle de dor musculoesquelética e diferente do 20203020.

Outras técnicas que podem integrar o plano terapêutico perineal que cabem liberação pelo20203020:

📌 *Cone vaginal ou dispositivos resistivos*
📌 *Treino sensório-retal com balão (incontinência fecal, constipação)*

⚠️ Atenção: para casos vesico-uretrais, antes de liberar o código, observar se a eletroestimulação foi de fato realizada pelo prestador e pedida pelo médico. Conforme já exposto na seção Pedido Médico x Cobrança:

📌 Prestador realizou, mas médico não pediu (casos normais sem suspeitas): solicitar **A206 A uma vez, não reiterar complemento**. Se não for enviado, liberar conforme código 20103190.

📌 Prestador cobrou somente como [fisioterapia] e médico solicitou eletroestimulação:

- Casos normais sem suspeitas: liberar 20203020.
- Casos com abuso ou suspeitas: liberar 20103190.

➡️ Não cabe liberação concomitante de 20103190 + 20203020. Liberar somente 20203020, se aplicável.



TUSS 20103107 - Atendimento fisiátrico no pré e pós-parto

Exemplos de indicação: preparação para o parto (treinamento respiratório, mobilidade pélvica, consciência corporal); dores musculoesqueléticas gestacionais (dor lombar gestacional, dor pélvica, dor sacroilíaca); alterações posturais na gestação (hiperlordose gravídica); prevenção de lesões no assoalho pélvico durante a gestação; reabilitação pós-parto (recuperação funcional, dor pélvica pós-parto); correção de padrões musculares alterados no pós-parto (fraqueza abdominal profunda, instabilidade lombo-pélvica); disfunção abdominal pós-parto (diástase abdominal vinculada à gestação, redução da estabilidade do core)

🎯 Este código se refere ao atendimento fisioterapêutico voltado para o período gestacional e puerperal, com foco na prevenção e recuperação funcional global. O objetivo é preparar a gestante para o parto, promover bem-estar durante a gravidez e auxiliar na reabilitação pós-parto, contemplando aspectos musculoesqueléticos, posturais e funcionais, sem caráter de tratamento específico para disfunções urinárias ou fecais.

Este código não deve ser utilizado para tratamento específico de incontinência urinária ou fecal, mesmo que seja causada pela gestação. Incontinência urinária na gestação é uma **condição clínica que requer abordagem específica**, não apenas preventiva, sendo a PFMT a primeira linha de tratamento. Portanto, **não usar o código pré/pós-parto para tratar incontinência**, pois isso descaracteriza a finalidade do código.

Para IU (incontinência urinária), utilizar **20103190 (disfunção vésico-uretral)** ou **20103646 (Reabilitação perineal com biofeedback)**, quando esta técnica estiver claramente indicada e realizada.

Ressalta-se que a eletroestimulação intracavitária durante a gestação não tem contraindicação absoluta, embora haja condições não recomendáveis, conforme já disposto no item anterior 20203020.

Fora as técnicas de assoalho tratadas à parte, no pré-parto as condutas podem envolver treino respiratório e relaxamento (técnicas diafragmáticas para controle da dor e ansiedade), mobilizações pélvicas e exercícios de quadril, uso de bola suíça e posições facilitadoras.

Já no pós-parto, podem ser utilizados, entre outros: exercícios para diástase abdominal (estabilização do core), técnicas para controle da dor etc.



TUSS 20103646 - Reabilitação perineal com biofeedback

Exemplos de indicação: incontinência urinária (esforço, urgência, mista); bexiga hiperativa; retenção urinária; bexiga neurogênica; incontinência fecal; incontinência de gases; constipação funcional crônica; anismo; dor pélvica crônica; síndrome do assoalho pélvico hiperativo; prolapsos genitais; vaginismo; dispareunia; alterações musculares que impactam função sexual; reabilitação pós-operatória após cirurgias pélvicas (histerectomia, prostatectomia, sling uretral, retopexia)

🎯 O biofeedback é uma técnica que utiliza sensores (pressão ou eletromiografia) para fornecer **feedback visual ou sonoro** sobre a contração e relaxamento dos músculos do assoalho pélvico, ajudando o paciente a **identificar e executar corretamente os movimentos**. Pode ser aplicado por **sonda via vaginal ou anal**, ou **com eletrodos superficiais**, sempre sob supervisão de fisioterapeuta especializado.

O biofeedback não é considerado tratamento de primeira linha para disfunções pélvicas. Ele é um recurso complementar, utilizado quando há dificuldade de percepção muscular, necessidade de refinar a técnica ou em casos selecionados conforme avaliação médica/fisioterapêutica. Os tratamentos de primeira linha variam conforme a condição (PFMT, terapia comportamental, educação miccional, terapia manual, manejo da dor etc.).

⚠️ Liberar esse código apenas se atendidos os três critérios a seguir: **1)** a indicação estiver relacionada a região pélvica/perineal; **2)** a técnica for solicitada pelo médico assistente e **3)** o prestador descrever a utilização da técnica em relatório.

Para mais detalhes das regras de liberação, verificar seção Pedido Médico x Cobrança.

Não confundir com o código TUSS 20103131 - Biofeedback com EMG. Este deve ser reservado a utilização de biofeedback por eletromiografia não relacionada ao assoalho pélvico.

📌 Não cabe liberação concomitante de 20103190 + 20103646. Liberar somente 20103646 se o caso atender aos critérios.

📌 Quanto à cobrança de 20203020 + 20103646: A reabilitação perineal pode incluir, quando clinicamente indicado, a associação de biofeedback (Código TUSS 20103646) e eletroestimulação do assoalho pélvico (Código TUSS 20203020) na mesma sessão. Essa combinação é aceita em protocolos de fisioterapia pélvica para potencializar resultados. A associação **20103646 + 20203020** só deve ser **liberada** quando **ambas** estiverem **explicitamente prescritas** e **documentadas** (relatório detalha a execução + pedido médico).

📌 Ressalta-se que a eletroestimulação intracavitária durante a gestação não tem contraindicação absoluta, embora haja condições não recomendáveis, conforme já disposto no item anterior 20203020. Quanto ao biofeedback realizado com sonda vaginal em gestantes, não há estudos que sinalizem contraindicação específica, não sendo possível efetuar negativas ou pendências. O biofeedback apenas capta e exibe a atividade muscular do assoalho pélvico, não há estímulo com aplicação de corrente elétrica.

TUSS 20103131 - Biofeedback com EMG



Exemplos de indicação: reabilitação neuromuscular pós-operatória; reabilitação de controle motor/padrões do movimento; distúrbios musculoesqueléticos; reeducação neuromuscular na neurologia; disfunções de coordenação e propriocepção; condições esportivas

🎯 O biofeedback com EMG é uma técnica de reabilitação neuromuscular que utiliza **eletromiografia de superfície** para captar a atividade elétrica de músculos esqueléticos e fornecer ao paciente um retorno visual ou sonoro em tempo real. Eletrodos adesivos são posicionados sobre o músculo-alvo (como quadríceps, glúteo médio etc.), permitindo que o paciente visualize a ativação muscular durante o movimento.

O objetivo é melhorar o controle motor, corrigir padrões inadequados de ativação, recrutar músculos pouco ativados, reduzir compensações, acelerar a recuperação pós-operatória e aumentar a precisão da contração muscular em contextos ortopédicos, neurológicos e esportivos.

O biofeedback com EMG não constitui tratamento de primeira linha para as condições musculoesqueléticas ou neurológicas, sendo utilizado como ferramenta complementar em casos selecionados. Seu uso é indicado quando há dificuldade de ativação muscular, necessidade de aprimoramento do controle motor ou reeducação neuromuscular específica. Em pacientes que respondem bem ao fortalecimento convencional, treino funcional e exercícios de controle motor sem feedback instrumental, o biofeedback EMG não é necessário.

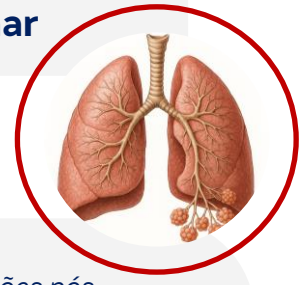
Não confundir o uso com o 20103646, que é reservado a disfunções perineais e vésico-uretrais.

⚠️ Liberar esse código apenas se atendidos os seguintes critérios: **1)** a técnica for solicitada pelo médico assistente e **2)** o prestador **cobrar a técnica** e descrever sua utilização em relatório, inclusive descrevendo o uso do aparelho de eletromiografia.

Para mais detalhes das regras de liberação, verificar seção Pedido Médico x Cobrança.

📌 Não cabe liberação concomitante de código de patologia + 20103131, pois o biofeedback já engloba o ato fisioterapêutico. Liberar somente 20103131 se o caso atender aos critérios.

Códigos de fisioterapia respiratória/cardiopulmonar



TUSS 20103220 - Doenças pulmonares atendidas em ambulatório

Exemplos de indicação: pneumonia; bronquite aguda; tuberculose; bronquiolite; infecções pós-virais com complicação pulmonar; infecções virais graves

🎯 Este código deve ser utilizado para fisioterapia respiratória em pacientes com doenças pulmonares tratadas em regime ambulatorial, que não se enquadram nos códigos específicos (DPOC, asma, sinusite ou pré/pós-operatório). As doenças pulmonares referem-se a condições que comprometem a ventilação e/ou a troca gasosa, podendo causar inflamação, acúmulo de secreções, redução da complacência pulmonar ou alteração da mecânica respiratória. A fisioterapia atua para otimizar a função respiratória, promover higiene brônquica e prevenir complicações.

As abordagens incluem avaliação fisioterapêutica respiratória, técnicas de higiene brônquica (como drenagem postural e vibrocompressão), exercícios respiratórios para expansão pulmonar, uso de dispositivos de incentivo.

TUSS 20103360 - Paciente com D.P.O.C. em atendimento ambulatorial necessitando reeducação e reabilitação respiratória

Exemplos de indicação: bronquite crônica; enfisema pulmonar

🎯 A DPOC é um grupo de doenças respiratórias crônicas caracterizadas por limitação persistente do fluxo aéreo, geralmente não totalmente reversível, associada à inflamação crônica das vias aéreas e destruição do parênquima pulmonar. Os principais fenótipos são:

- **Bronquite crônica** – tosse produtiva por ≥ 3 meses/ano, por pelo menos 2 anos consecutivos.
- **Enfisema pulmonar** – destruição dos alvéolos, perda da elasticidade pulmonar e hiperinsuflação.
- **Forma mista** – combinação de bronquite crônica e enfisema.

A fisioterapia respiratória tem como objetivo melhorar a mecânica respiratória e a ventilação alveolar, reduzir a dispneia e otimizar a oxigenação, além de promover técnicas de higiene brônquica para controle de secreções. Também busca reeducar padrões respiratórios, fortalecer a musculatura respiratória e contribuir para a melhora da capacidade funcional e da qualidade de vida, reduzindo o risco de exacerbações e hospitalizações.

Podem ser realizadas técnicas de higiene brônquica (drenagem postural, vibrocompressão), exercícios respiratórios para expansão pulmonar, treino diafragmático, uso de dispositivos de incentivo e fortalecimento da musculatura respiratória. **Asma não é DPOC** e tem código próprio (20103255).

TUSS 20103255 - Exercícios para reabilitação do asmático (ERAI) - por sessão individual



Exemplos de indicação: asma

🎯 **Asma** é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas, caracterizada por episódios recorrentes de falta de ar, chiado no peito, tosse e sensação de aperto no tórax.

A asma não é considerada DPOC porque apresenta mecanismos fisiopatológicos distintos: enquanto a DPOC envolve limitação persistente e não totalmente reversível do fluxo aéreo, geralmente associada a bronquite crônica e enfisema, a asma caracteriza-se por obstrução variável e reversível, com inflamação das vias aéreas e hiperresponsividade brônquica por estímulos como poeira, fumaça, mudanças de temperatura, esforço físico ou alérgenos. Além disso, a resposta ao tratamento é diferente, sendo a asma altamente responsiva a broncodilatadores e corticosteroides, ao passo que a DPOC mantém obstrução mesmo após terapia.

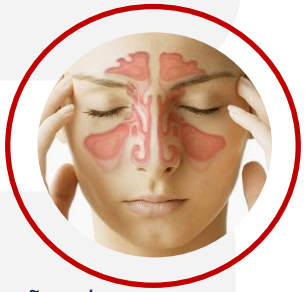
São feitos exercícios respiratórios para expansão pulmonar, treino diafragmático, técnicas de controle da respiração (como respiração com lábios semicerrados), uso de dispositivos de incentivo, exercícios aeróbicos leves e progressivos, fortalecimento da musculatura respiratória e global.

TUSS 20103069 - Assistência fisiátrica respiratória em pré e pós-operatório de condições cirúrgicas

Exemplos de indicação: cirurgias abdominais (bariátrica, colecistectomia, hérnia, apendicectomia); cirurgias torácicas (lobectomia, mastectomia, cirurgia cardíaca); procedimentos que envolvam anestesia geral e risco de complicações respiratórias

🎯 Este código é utilizado para fisioterapia respiratória em pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos, com foco na **prevenção e tratamento de complicações respiratórias** no período pré e pós-operatório. A intervenção fisioterapêutica é essencial para otimizar a função pulmonar, reduzir risco de atelectasia, pneumonia e tromboembolismo, além de acelerar a recuperação funcional.

Visa melhorar a ventilação alveolar, promover higiene brônquica, prevenir complicações pulmonares, reduzir dor relacionada à mecânica respiratória e reeducar padrões ventilatórios. No pré-operatório, busca preparar o paciente para o procedimento, enquanto no pós-operatório atua para restaurar a função respiratória e prevenir sequelas.



TUSS 20103719 - Sinusites

Exemplos de indicação: sinusite aguda ou crônica

🎯 Este código refere-se ao tratamento fisioterapêutico de **sinusites**, que são inflamações dos seios paranasais, que fazem parte das **vias aéreas superiores**, podendo ser **agudas ou crônicas**. Não envolvem comprometimento da ventilação pulmonar ou troca gasosa, não se aplicando, portanto, o código 20103220. As causas mais comuns incluem infecções virais, bacterianas ou fúngicas, além de alergias e fatores que obstruem as vias nasais, dificultando a drenagem das secreções.

A intervenção visa melhorar a ventilação das vias aéreas superiores, facilitar a drenagem das secreções e reduzir sintomas como congestão e dor facial. As técnicas podem incluir drenagem postural, manobras para higiene das vias aéreas, exercícios respiratórios e, em alguns casos, recursos complementares como nebulização.



Códigos de fisioterapia em regime de internação

TUSS 20203047 - Assistência fisiátrica respiratória em doente clínico internado

Exemplos de indicação: paciente internado com doença pulmonar aguda ou crônica descompensada; pós-operatório clínico com risco de complicações respiratórias

🎯 Este procedimento destina-se a pacientes internados com comprometimento respiratório decorrente de condições clínicas, que apresentam risco de complicações respiratórias decorrentes da imobilidade ou da doença de base. A fisioterapia respiratória tem como finalidade **prevenir e tratar complicações pulmonares**, como atelectasia, retenção de secreções e infecções respiratórias, além de otimizar a função ventilatória.

As condutas incluem avaliação fisioterapêutica respiratória completa, técnicas de higiene brônquica (drenagem postural, vibrocompressão), exercícios respiratórios (inspiração profunda, treino diafragmático), uso de dispositivos de incentivo e mobilização precoce, quando possível.

TUSS 20203012 - Assistência fisiátrica respiratória em paciente internado com ventilação mecânica

Exemplos de indicação: paciente em UTI com ventilação mecânica prolongada; pós-operatório de cirurgia de grande porte com necessidade de suporte ventilatório

🎯 Este procedimento destina-se a pacientes internados sob ventilação mecânica invasiva ou não invasiva, que apresentam risco de complicações respiratórias decorrentes da ventilação prolongada e da imobilidade. A fisioterapia respiratória tem como finalidade otimizar a mecânica ventilatória, prevenir complicações como pneumonia associada à ventilação, atelectasias e retenção de secreções, além de auxiliar no processo de desmame ventilatório.

As abordagens incluem ajuste e monitoramento da interação paciente-ventilador, aspiração traqueal conforme protocolos, mobilização passiva ou ativa conforme tolerância, técnicas para manutenção da complacência pulmonar e treino progressivo para desmame.



TUSS 20203071 - Pacientes em pós-operatório de cirurgia cardíaca, hospitalizado, até 8 semanas de programa

Exemplos de indicação: pós-operatório imediato de cirurgia cardíaca (ex.: revascularização do miocárdio, troca valvar); paciente internado em UTI ou enfermaria após procedimento cardíaco com risco de complicações respiratórias e motoras

🎯 Este procedimento destina-se a pacientes hospitalizados no pós-operatório de cirurgia cardíaca, com o objetivo de prevenir complicações respiratórias, musculoesqueléticas e circulatórias, além de promover recuperação funcional segura. A fisioterapia atua para otimizar a ventilação pulmonar, prevenir atelectasias, reduzir risco de infecção, melhorar a mobilidade e auxiliar na retomada gradual das atividades.

Compreende exercícios respiratórios com dispositivos de incentivo, técnicas de higiene brônquica, mobilização precoce (passiva, ativa-assistida e ativa), treino de sedestação e ortostatismo, exercícios leves para membros, monitoramento da resposta cardiovascular ao esforço.

Após 8 semanas de internação, se o paciente ainda continuar internado, pode-se utilizar o código 20103727 (Reabilitação cardíaca supervisionada. Programa de 12 semanas. Duas a três sessões por semana [por sessão]) para continuidade da RCV supervisionada no hospital, com justificativa clínica. Para mais informações sobre **RCV**, consulte a seção “Códigos de fisioterapia cardiovascular”.

TUSS 20203063 - Pacientes com doença isquêmica do coração, hospitalizado, até 8 semanas de programa

Exemplos de indicação: internação por angina instável; pós-infarto agudo do miocárdio (tratamento clínico ou angioplastia); paciente com insuficiência coronariana em fase aguda ou subaguda

🎯 Este procedimento destina-se a pacientes hospitalizados com doença isquêmica do coração, visando prevenir complicações cardiovasculares, otimizar a função cardiorrespiratória e promover recuperação funcional segura. A fisioterapia atua para melhorar a tolerância ao esforço, reduzir risco de eventos tromboembólicos, prevenir perda muscular e auxiliar na retomada gradual das atividades, sempre respeitando parâmetros hemodinâmicos e protocolos de segurança.

É feita avaliação fisioterapêutica completa com monitoramento de sinais vitais, exercícios respiratórios para otimização da ventilação, mobilização precoce (passiva, ativa-assistida e ativa), treino de sedestação e ortostatismo, exercícios leves para membros com progressão controlada.

Após 8 semanas de internação, se o paciente ainda continuar internado, pode-se utilizar o código 20103727 (*Reabilitação cardíaca supervisionada. Programa de 12 semanas. Duas a três sessões por semana [por sessão]*) para continuidade da **RCV** supervisionada no hospital, com justificativa clínica. Para mais informações sobre **RCV**, consulte a seção “Códigos de fisioterapia cardiovascular”.



TUSS 50000365 - Atendimento fisioterapêutico hospitalar ao paciente com disfunção decorrente de alterações do sistema músculo-esquelético

Exemplos de indicação: pós-operatório ortopédico; disfunções musculoesqueléticas por trauma ou imobilização prolongada; alterações decorrentes de doenças reumáticas ou congênitas; comprometimento neuromuscular associado à internação

🎯 Este procedimento destina-se a pacientes hospitalizados que apresentam disfunções musculoesqueléticas, sejam elas decorrentes de trauma, cirurgia ortopédica, doenças reumáticas, alterações congênitas ou condições neuromusculares. O objetivo é prevenir complicações como rigidez articular, perda de força, trombose venosa profunda e comprometimento funcional, além de promover recuperação segura e otimizar a mobilidade.

As condutas podem envolver mobilização precoce (passiva, ativa-assistida e ativa), exercícios para manutenção ou ganho de amplitude de movimento, fortalecimento progressivo, treino funcional (sedestação, ortostatismo, marcha), técnicas para controle da dor (termoterapia, eletroterapia).

TUSS 50000390 - Atendimento fisioterapêutico hospitalar ao paciente com disfunção decorrente de queimaduras

Exemplos de indicação: paciente internado com queimaduras extensas em membros ou tronco; pós-cirurgia para enxertos cutâneos; queimaduras que comprometem mobilidade articular ou função respiratória

🎯 Este procedimento destina-se a pacientes hospitalizados com disfunções decorrentes de queimaduras, que podem causar restrição de movimento, dor intensa, risco de contraturas e comprometimento funcional. A fisioterapia tem como objetivo prevenir deformidades, manter ou recuperar amplitude de movimento, reduzir dor, preservar função respiratória (quando há envolvimento torácico) e preparar para reabilitação pós-alta.

As abordagens podem envolver posicionamento funcional para prevenção de contraturas, mobilização precoce (passiva e ativa conforme tolerância), exercícios para manutenção da amplitude articular, técnicas para controle da dor (termoterapia, eletroterapia quando permitido), treino respiratório em casos de queimaduras torácicas, orientações para cuidados com enxertos e prevenção de complicações circulatórias.



TUSS 50000403 - Atendimento fisioterapêutico hospitalar ao paciente com disfunção decorrente de alterações do sistema linfático e/ou vascular periférico

Exemplos de indicação: linfedema pós-cirurgia oncológica ou pós-trauma; edema importante por insuficiência venosa crônica; alterações vasculares periféricas associadas à imobilização prolongada

🎯 Este procedimento destina-se a pacientes hospitalizados que apresentam disfunções decorrentes de alterações do sistema linfático e/ou vascular periférico, como linfedema ou edema venoso significativo. O objetivo da fisioterapia é reduzir o edema, prevenir complicações como infecções e trombose, melhorar a circulação periférica e preservar a funcionalidade do membro acometido.

As condutas podem envolver posicionamento adequado para drenagem, mobilização precoce, exercícios ativos para estímulo circulatório, técnicas de drenagem linfática manual (quando indicadas), cuidados com compressão elástica conforme protocolo médico.

TUSS 50000454 - Atendimento fisioterapêutico hospitalar para alterações inflamatórias e ou degenerativas do aparelho genito-urinário, reprodutor e/ou proctológico

Exemplos de indicação: processos inflamatórios pélvicos (ex.: doença inflamatória pélvica, endometrite, prostatite); pós-operatório complexo urológico, ginecológico ou proctológico com risco funcional

🎯 Este procedimento destina-se a pacientes hospitalizados com disfunções decorrentes de alterações inflamatórias ou degenerativas do aparelho genito-urinário, reprodutor ou proctológico. O objetivo é prevenir complicações como dor crônica, aderências e perda funcional do assoalho pélvico, além de promover recuperação segura.

As condutas podem envolver técnicas para analgesia e relaxamento pélvico, exercícios respiratórios associados à mobilidade pélvica, mobilização precoce.

Este código não deve ser utilizado para atendimento pós-parto fisiológico ou cesariana sem complicações. Para esses casos, utilizar o código 20103107 – Atendimento fisiátrico no pré e pós-parto, que é o único disponível para essa finalidade, mesmo quando o atendimento ocorre em regime hospitalar.



TUSS 50000799 - Atendimento fisioterapêutico hospitalar ao paciente independente ou com dependência parcial, com disfunção decorrente de lesão do sistema nervoso central e/ou periférico

Exemplos de indicação: acidente vascular cerebral (AVC) com déficit motor leve a moderado; traumatismo cranioencefálico com recuperação funcional parcial; lesões medulares incompletas; neuropatias periféricas com preservação parcial da mobilidade

🎯 Destina-se a pacientes hospitalizados que apresentam disfunções neurológicas decorrentes de lesões do SNC ou SNP, mas que mantêm **independência ou dependência parcial**. O objetivo é prevenir complicações secundárias (contraturas, úlceras de pressão, perda funcional), promover mobilidade segura e otimizar a recuperação neurológica.

As condutas possíveis podem ser mobilização precoce e posicionamento funcional, exercícios passivos e ativos assistidos para manutenção de amplitude articular, treino respiratório e prevenção de complicações pulmonares e estímulo sensório-motor para reorganização neurológica.

TUSS 50000802 - Atendimento fisioterapêutico hospitalar ao paciente dependente com disfunção decorrente de lesão do sistema nervoso central e/ou periférico

Exemplos de indicação: acidente vascular cerebral (AVC) com dependência funcional total; lesão medular completa; traumatismo cranioencefálico grave; polineuropatias severas com perda de mobilidade

🎯 Destina-se a pacientes hospitalizados com **dependência** funcional significativa decorrente de lesões neurológicas centrais ou periféricas. O objetivo é prevenir complicações secundárias (contraturas, úlceras de pressão, complicações respiratórias), manter funções vitais e promover mobilidade mínima segura.

As abordagens possíveis podem ser mobilização passiva e posicionamento para prevenção de deformidades, exercícios respiratórios para otimizar ventilação e prevenir atelectasias, Estímulos sensório-motores para manutenção de trofismo muscular, técnicas para prevenção de complicações circulatórias e pulmonares.

Códigos de fisioterapia cardiovascular



1. Conceito Geral e Definições da Reabilitação Cardiovascular (RCV)

A **Reabilitação Cardiovascular** (RCV) é definida como o conjunto de atividades necessárias para garantir que pessoas com Doenças Cardiovasculares (DCV) atinjam uma condição física, mental e social ótima, permitindo-lhes ocupar um lugar o mais normal possível na sociedade.

A RCV é uma estratégia de intervenção multidisciplinar e um componente essencial do tratamento clínico pleno das DCV. Ela é comprovadamente eficaz na redução da morbimortalidade cardiovascular e global, além de promover um expressivo ganho na qualidade de vida.

O objetivo principal é atingir uma melhora dos componentes da aptidão física – tanto aeróbicos quanto não aeróbicos (força/potência muscular, flexibilidade, equilíbrio) – de modo a reduzir o risco de eventos cardiovasculares.

A segurança do programa de reabilitação cardiovascular é garantida pela adequada estratificação de risco dos pacientes e pela disponibilidade de recursos essenciais no local das sessões, incluindo cardiodesfibrilador e materiais de suporte básico e avançado de vida.

Pacientes de alto risco, como aqueles com descompensação recente ou baixa capacidade funcional (< 5 METs), requerem monitoramento mais rigoroso, podendo incluir aferição de frequência cardíaca, pressão arterial, saturação de oxigênio, glicemia e, quando indicado, monitorização eletrocardiográfica. O ambiente deve dispor de equipamentos apropriados para exercícios aeróbicos e fortalecimento muscular, assegurando a abrangência dos componentes da aptidão física e a segurança durante toda a intervenção.

A RCV é indicada para pacientes em **prevenção secundária** (após um evento cardíaco) e para pacientes em **prevenção primária** (alto risco), abrangendo um amplo espectro de condições.

Pacientes elegíveis incluem (mas não se limitam a):

- Pós-Eventos/Intervenções: Infarto Agudo do Miocárdio (IAM), Síndrome Coronariana Aguda (SCA), Cirurgia de Revascularização do Miocárdio (CRVM), Intervenção Coronária Percutânea (ICP, como stent), reparo ou troca valvular, Transplante Cardíaco (TxC), e Portadores de Marcapasso (MP) ou Cardioversor Desfibrilador Implantável (CDI).
- Condições Crônicas: Angina estável, Insuficiência Cardíaca (IC) crônica, Doença Arterial Obstrutiva Periférica (DAOP), e outras cardiopatias específicas.
- Alto Risco (Prevenção Primária): Pacientes sem doença cardiovascular manifesta, mas com múltiplos fatores de risco descontrolados (e.g., Hipertensão Arterial Sistêmica – HAS, Diabetes Mellitus – DM) e classificados como de alto risco cardiovascular.

Definições sobre Doença Arterial Coronariana

DAC é uma condição clínica caracterizada por obstrução das artérias coronárias, geralmente por aterosclerose.

- Pode ser tratada clinicamente (medicação, mudança de estilo de vida) ou com intervenções (ICP – angioplastia com stent, ou CRVM – cirurgia de revascularização).

A definição de pós-cirúrgico refere-se a pacientes que já passaram por uma intervenção aberta, como:

- CRVM (cirurgia de ponte de safena/mamária)
- Reparo ou troca valvar
- Transplante cardíaco

Portanto, nem todo paciente com DAC é cirúrgico, e muitos permanecem apenas em tratamento clínico. A angioplastia com stent é invasivo, mas não é cirúrgico aberto, portanto, não se enquadra como pós-cirúrgico. Os códigos são distintos para os dois cenários.



2. Estrutura, Fases e Componentes da RCV

A RCV é um programa estruturado, caracterizado pela atuação de uma equipe especializada e por um sistema de fases progressivas.

A. Equipe Multiprofissional

O núcleo da equipe é formado por médicos (líderes, responsáveis pela avaliação e limites de segurança), educadores físicos, fisioterapeutas (que atuam na prescrição e supervisão dos exercícios), e profissionais de enfermagem. Outros profissionais, como nutricionistas e psicólogos/assistentes sociais, são importantes para o tratamento integral e educacional.
Embora não haja diretriz rígida sobre os limites de atuação, o fisioterapeuta normalmente atua como executor nas fases 1 e 2 e o educador físico nas fases 3 e 4.

- São passíveis de reembolso atendimentos feitos por fisiatra, fisioterapeuta e cardiologistas. Se realizado por educador físico, negar com **N226**.

B. Fases da Reabilitação Cardiovascular

A **duração da RCV pode variar** conforme o quadro clínico e a evolução do treinamento físico. O enquadramento, a manutenção ou a reclassificação do perfil de risco devem ser determinados pela avaliação médica pré-participação e por reavaliações subsequentes, realizadas pelo médico e demais integrantes da equipe. As durações apresentadas são médias estimadas, podendo variar conforme a evolução clínica individual, conforme evidências científicas.

Fase 1 – Hospitalar

- **Quando ocorre:** Durante a internação, logo após o evento agudo (ex: infarto, cirurgia cardíaca, angioplastia).
- **Local:** Intra-hospitalar.



- **Objetivos:**
  - Prevenir perda de capacidade funcional e complicações do repouso prolongado.
  - Iniciar mobilização precoce e orientar sobre autocuidado.
  - Reduzir ansiedade, depressão e risco de complicações respiratórias e tromboembólicas.
- **Atividades:**
  - Feitas com monitorização. Envolve exercícios respiratórios quando indicados, mobilização leve de curta duração no leito, sedestação e ortostatismo, treino funcional básico, deambulação no quarto ou corredor do hospital.
  - Educação sobre a doença, fatores de risco e importância da reabilitação.
- **Duração:**
  - Do momento da estabilização clínica até a alta hospitalar.

Fase 2 – Ambulatorial (Convalescença)

- **Quando ocorre:** Após a alta hospitalar, geralmente nas primeiras semanas a meses.
- **Local:** Ambulatorial (clínica/centro de reabilitação).
- **Objetivos:**
  - Recuperar a capacidade funcional e promover adaptação ao esforço.
  - Iniciar exercícios supervisionados, com progressão gradual de intensidade.
  - Trabalhar controle de fatores de risco e adesão ao tratamento.
- **Atividades:**
  - É feito com monitorização dos parâmetros clínicos (FC, PA, SpO2, sintomas e escala de Borg). Engloba exercícios aeróbicos (esteira, bicicleta ergométrica, elíptico com progressão), de resistência (pesos leves, faixa elástica), exercícios de flexibilidade e alongamento. Pode haver treino respiratório adjuvante quando indicado, para otimizar desempenho no exercício (padrão ventilatório, inspirometria/IMT [Inspiratory Muscle Training]).
  - Sessões supervisionadas por equipe multiprofissional (médico, fisioterapeuta, educador físico etc.).
  - Educação continuada e apoio psicológico.

- **Duração:**
  - Em média de 1 a 3 meses, podendo variar conforme evolução do paciente.

Fase 3 – Manutenção Precoce

- **Quando ocorre:** Após a fase 2, com o paciente já adaptado ao programa.
- **Local:** Ambulatorial ou semissupervisionado (em ambiente externo ao de saúde).
- **Objetivos:**
  - Manter ou aumentar a capacidade funcional.
  - Consolidar mudanças de estilo de vida e promover autonomia.
  - Reduzir risco de novos eventos cardiovasculares.
- **Atividades:**
  - Exercícios regulares (3 a 5 vezes por semana), podendo ser supervisionados ou semissupervisionados.
  - Monitoramento periódico da evolução clínica e funcional.
- **Duração:**
  - De 3 a 6 meses, podendo se estender conforme necessidade.

Fase 4 – Manutenção Tardia / Vida Longa

- **Quando ocorre:** Após completar as fases anteriores.
- **Local:** Domiciliar (RCVD) ou em academias.
- **Objetivos:**
  - Estimular a prática de atividade física regular e manutenção dos hábitos saudáveis ao longo da vida.
  - Prevenir recaídas e garantir adesão ao tratamento.

- **Atividades:**
  - Exercícios físicos incorporados à rotina diária, com ou sem supervisão.
  - Reavaliações periódicas para ajuste da prescrição e reforço das orientações.
- **Duração:**
  - Indeterminada, idealmente para toda a vida.



3. Interpretação dos Códigos TUSS na Perspectiva da RCV

Os códigos TUSS em sua temporalidade e foco se alinham às fases 1 e 2 da RCV, sendo a Fase 2 (Supervisionada) o período mais frequentemente detalhado.
Conforme exposto, a RCV realizada em clínica não se trata de fisioterapia convencional, sendo um conjunto de intervenções complexas. O fato de o paciente apresentar diagnóstico cardiológico (ex: insuficiência cardíaca, fibrilação atrial) não significa, por si só, que está sendo submetido a um programa de reabilitação cardiovascular. É fundamental analisar o pedido médico e o relatório do fisioterapeuta: se a conduta está voltada para reabilitação motora, respiratória ou funcional geral, sem os elementos característicos da RCV (estratificação de risco, monitoramento, protocolos específicos), o enquadramento deve ser como fisioterapia convencional.
Se não houver relatório do prestador e o médico não indicou reabilitação cardíaca de forma explícita (e sim fisioterapia cardiopulmonar, motora, entre outras), aguardar **A107** a fim de identificar o atendimento de fato realizado.

TUSS 20103379 - Paciente em pós-operatório de cirurgia cardíaca, atendido em ambulatório, duas a três vezes por semana

🎯 Código exclusivo para RCV em pacientes no pós-operatório de cirurgias cardíacas, incluindo revascularização, cirurgias valvares e congênitas, normalmente se encaixando na Fase 2 Pós-Alta. A intervenção exige cuidados específicos, como restrições de carga nos Membros Superiores (MMSS) nas primeiras 6 a 8 semanas devido à esternotomia.

TUSS 20103395 - Pacientes com doença isquêmica do coração, atendido em ambulatório, até 8 semanas de programa

🎯 Corresponde ao início da RCV em pacientes com doença isquêmica, representando a etapa inicial da Fase 2. Indicado nas primeiras 8 semanas após evento ou em casos estáveis, com foco na convalescença inicial.

O analista deve verificar a **data de início do programa ambulatorial e comparar com a data do seu evento**:

- Se estiver **até 8 semanas**, utilizar este código (20103395).
- Se estiver **entre 8 e 24 semanas**, aplicar **TUSS 20103387**.

Se o paciente estiver em pós-operatório de cirurgia cardíaca, utilizar **TUSS 20103379**.

TUSS 20103387 - Pacientes com doença isquêmica do coração, atendido em ambulatório de 8 a 24 semanas

🎯 Representa a continuidade do programa ambulatorial após o período inicial (até 8 semanas), Fase 2. Corresponde à progressão dos exercícios e à consolidação da estabilidade clínica, normalmente entre 8 e 24 semanas após o evento. A transição para a Fase 3 (manutenção precoce) depende da avaliação clínica individual, podendo ocorrer antes ou depois desse período, conforme a evolução do paciente.

Verificar a **data de início do programa ambulatorial e comparar com a data do evento do sinistro:**

- Se **até 8 semanas**, aplicar **TUSS 20103395**.
- Se **entre 8 e 24 semanas**, aplicar **este código (20103387)**.
- Se pós-operatório de cirurgia cardíaca, aplicar **TUSS 20103379**.
- Se **após 24 semanas** e houver indicação para a continuidade, aplicar **20103727**.

TUSS 20103417 – Pacientes sem doença coronariana clinicamente manifesta, mas considerada de alto risco, atendido em ambulatório, duas a três vezes por semana

🎯 Quando falamos em doença isquêmica do coração, estamos nos referindo à consequência da DAC (**doença arterial coronariana**), que é a obstrução das artérias coronárias levando à redução do fluxo sanguíneo para o miocárdio (isquemia).

Nem todo paciente com DAC apresenta sintomas; alguns estão em fase assintomática ou apenas em prevenção.

Para a doença coronária assintomática, é realizada RCV com modelo estrutural da fase 2 em diante, com ajuste da intensidade conforme o perfil clínico. É direcionada ao controle de fatores de risco, não à recuperação pós-evento.

Orientações:

- **Não se aplica a pacientes com doença coronariana já manifesta** (nesses casos, usar códigos específicos como 20103395, 20103387 ou 20103727).
- Confirmar que **não há diagnóstico clínico ou evento coronariano prévio** (infarto, angina instável, angioplastia, cirurgia cardíaca).



TUSS 20103727 - Reabilitação cardiovascular supervisionada. Programa de 12 semanas. Duas a três sessões por semana (por sessão)

🎯 A nomenclatura deste código é abrangente, podendo ser aplicada tanto para situações intra-hospitalares (ver códigos hospitalares 20203071 e 20203063) quanto ambulatoriais, e para todas as etiologias.

No entanto, estabelecem-se as seguintes relações e orientações:

- **Doença isquêmica:**
  Utilizar os códigos específicos para até 8 e 24 semanas; após esse período, migrar para o 20103727 se houver indicação clínica de continuidade da reabilitação supervisionada.
- **Pós-operatório de cirurgia cardíaca:**
  Manter o código específico 20103379, visto que não há restrição de tempo para sua utilização enquanto houver indicação clínica.
- **Alto risco:**
  Manter o código específico 20103417, exceto se houver cobrança específica pelo prestador ou solicitação formal do médico assistente para uso do 20103727. Isso porque a diferença de CRS entre os dois é considerável (o que não ocorre com isquemia nem pós-operatório), e a utilização do 20103417 pode gerar questionamentos.
- **Situação de internação prolongada:**
  Embora a nomenclatura do 20103727 remeta à RCV de Fase 2 ambulatorial (12 semanas), este código pode ser liberado após 8 semanas de internação, caso o paciente ainda esteja internado e necessite dar continuidade à RCV. Os códigos hospitalares limitam-se a 8 semanas, sendo o 20103727 a alternativa para continuidade do tratamento supervisionado em regime hospitalar, desde que devidamente justificado.



Código de fisioterapia linfática

TUSS 20103212- Distúrbios circulatórios artério-venosos e linfáticos

Exemplos de indicação: linfedema; lipedema; insuficiência venosa crônica (incluindo varizes, síndrome pós-trombótica, úlceras venosas e edema venoso); doença arterial periférica estável (especialmente na fase de reabilitação ou após revascularização); distúrbios circulatórios mistos (venoso e linfático)

🎯 A fisioterapia nesses casos tem como objetivos reduzir o edema e a dor, melhorar o retorno venoso e linfático, prevenir complicações como úlceras e infecções e promover ganho funcional.

As condutas incluem drenagem linfática manual, terapia compressiva (bandagens, meias elásticas), cinesioterapia e exercícios específicos para ativação da bomba muscular, cuidados com a pele, orientações posturais e de autocuidado, além do uso de recursos adjuvantes como pressoterapia ou laser terapêutico, quando indicado.

Atenção:

- Não pagamos com finalidade estética (ex.: redução de medidas). Se for o caso, negar com **N236** (acionar a consultoria para confirmação).
- Quanto à terapia compressiva, pagamos conforme sessão. Cobranças das bandagens e meias não são cobertas, **N253**.
- Pressoterapia e laser terapêutico são fora ROL (**N205**) ou fora tabela em pré-lei (**N336**).
- Sobre a drenagem linfática, já abordada neste manual.

Código de reeducação e/ou reabilitação de distúrbios craniofaciais

TUSS 20103654 - Recuperação funcional de distúrbios crânio-faciais

Exemplos de indicação: pós-cirurgia ortognática (correção de deformidades faciais); pós-trauma crânio-facial (fraturas, lesões musculares); disfunções temporomandibulares (DTM) com limitação funcional; pós-reconstrução de mandíbula ou maxila; plagiocefalia, bruxismo; alterações musculares secundárias a tumores ou ressecções cirúrgicas localizados na região crânio-facial

🎯 Voltado para reabilitação funcional de alterações musculoesqueléticas e neuromotoras da **região crânio-facial**, que podem comprometer mastigação, deglutição, fala, expressão facial e respiração. Geralmente indicado após cirurgias, traumas ou doenças que afetam a musculatura e articulações da face.

O encaminhamento por vezes é feito por cirurgião-dentista (CRO), o que é aceito, conforme já discorrido neste manual.

Plagiocefalia é uma deformidade craniana, geralmente em bebês, causada por pressão prolongada em uma área da cabeça (ex.: posição supina por muito tempo).
O tratamento pode envolver:

- **Reposicionamento e estimulação motora** (fisioterapia).
- **Órtese craniana (capacete)** para remodelar o crânio. Não há cobertura para órtese, devendo ser negada com a crítica **N253 RN 465** para apólices da lei.



As condutas podem envolver:

- **Exercícios de mobilidade facial**: movimentos ativos e passivos para lábios,
- bochechas, mandíbula.
- **Treino funcional de mastigação e deglutição**: exercícios com alimentos adaptados e dispositivos.
- **Fortalecimento muscular**: resistência manual ou com elásticos específicos para região facial.
- **Técnicas de liberação miofascial**: para reduzir aderências e melhorar amplitude.
- **Treino respiratório e fonatório**: integração com fonoaudiologia quando necessário.
- **Recursos complementares**: termoterapia, eletroestimulação para músculos faciais.

Códigos de reeducação e reabilitação neuro-músculo-esquelética

TUSS 20103271 - Hemiplegia

Exemplos de indicação: sequelas pós-AVC (isquêmico ou hemorrágico), com déficit motor unilateral, hemiplegia congênita; lesões neurológicas adquiridas (traumatismo cranioencefálico, tumores, infecções do SNC)

🎯 Reabilitação funcional de pacientes com hemiplegia, condição caracterizada por **paralisia completa de um lado do corpo**, geralmente causada por lesão neurológica central (ex.: AVC, traumatismo cranioencefálico).

O tratamento visa recuperar força e amplitude articular, melhorar equilíbrio e marcha, prevenir complicações secundárias e estimular mecanismos de neuroplasticidade. As intervenções recomendadas são cinesioterapia ativa e assistida, treino de marcha e equilíbrio, terapia de espelho e treino bilateral, estimulação sensorial e proprioceptiva, exercícios funcionais.



TUSS 20103263 - Hemiparesia

Exemplos de indicação: sequelas pós-AVC (isquêmico ou hemorrágico), com déficit motor unilateral; hemiparesia congênita; lesões neurológicas adquiridas (traumatismo cranioencefálico, tumores, infecções do SNC)

🎯 Hemiparesia é a **paralisia parcial de um lado do corpo**, geralmente decorrente de lesão neurológica central, como Acidente Vascular Cerebral (AVC), traumatismo cranioencefálico ou outras condições que afetam o sistema nervoso. Diferente da hemiplegia (paralisia completa), a hemiparesia mantém algum grau de movimento voluntário, mas com fraqueza significativa e alterações de tônus (espasticidade ou flacidez).

Os objetivos são recuperar força muscular e amplitude articular, melhorar equilíbrio, marcha e controle postural, prevenir complicações secundárias (contraturas, dor no ombro, deformidades), estimular mecanismos de neuroplasticidade para reintegração funcional.

As intervenções recomendadas são cinesioterapia ativa e assistida, treino de marcha e equilíbrio, terapia de espelho e treino bilateral, estimulação sensorial e proprioceptiva, exercícios funcionais, estimulação elétrica funcional (EEF) em casos selecionados.



TUSS 20103328 - Lesão nervosa periférica afetando um nervo com alterações sensitivas e/ou motoras

Exemplos de indicação: paralisia de Bell (lesão do nervo facial); neuropatia do nervo radial (ex.: compressão ou trauma); síndrome do túnel do carpo (nervo mediano); neuropatia ulnar (compressão no cotovelo ou punho); lesão traumática isolada de nervo periférico (ex.: corte ou fratura com dano nervoso)

🎯 Os **nervos periféricos** são estruturas do sistema nervoso que conectam o cérebro e a medula espinhal aos músculos, pele e órgãos. Eles funcionam como "cabos de comunicação", transmitindo sinais elétricos para controlar movimentos (função motora) e perceber sensações (função sensitiva), como toque, dor e temperatura. Quando um nervo é lesionado, essa comunicação é prejudicada, podendo causar fraqueza muscular, perda de sensibilidade, dor ou alterações funcionais.

O 20103328 refere-se ao atendimento fisioterapêutico para lesão de um único nervo periférico, que provoca alterações sensitivas (como perda de sensibilidade, parestesia) e/ou motoras (fraqueza, paralisia parcial ou total) no território inervado por esse nervo.
Essas lesões podem ocorrer por trauma, compressão, processos inflamatórios ou cirúrgicos, afetando a condução nervosa e a função muscular e sensorial do segmento corporal correspondente.

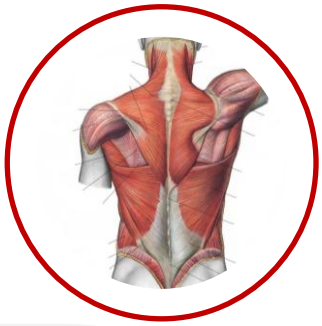
As condutas recomendadas podem envolver mobilização neural para reduzir aderências e melhorar condução, eletroestimulação (TENS/FES) para analgesia e recrutamento motor, exercícios terapêuticos (fortalecimento progressivo, treino funcional), reeducação sensitiva (estímulos táteis, térmicos e proprioceptivos).

TUSS 20103310 - Lesão nervosa periférica afetando mais de um nervo com alterações sensitivas e/ou motoras

Exemplos de indicação: polineuropatia periférica (ex.: diabética, tóxica); lesão múltipla do plexo braquial (trauma de alta energia); Síndrome de Guillain-Barré (comprometimento motor e sensitivo); polirradiculopatia (inflamatória ou traumática); sequelas pós-trauma com lesão de vários nervos (ex.: amputações complexas)

🎯 Abrange o tratamento fisioterapêutico para lesões que comprometem dois ou mais nervos periféricos, resultando em déficits motores e sensitivos mais amplos, podendo envolver um membro inteiro ou múltiplos segmentos.
Essas condições geralmente decorrem de traumas complexos, polineuropatias, lesões extensas do plexo nervoso ou sequelas pós-cirúrgicas, exigindo abordagem global para restaurar mobilidade, força, sensibilidade e funcionalidade.

As abordagens podem incluir mobilização neural combinada para múltiplos segmentos, exercícios globais envolvendo cadeias musculares, eletroestimulação segmentar para diferentes grupos musculares, Terapia ocupacional associada para atividades de vida diária, Controle da dor neuropática com técnicas analgésicas e educação em dor.



TUSS 20103344 – Miopatias

🎯 **Miopatia** é um termo usado para descrever doenças sistêmicas ou genéticas que afetam diretamente o músculo, causando fraqueza, perda de força e, em alguns casos, alterações na estrutura muscular.
Diferente das doenças que atingem ossos, articulações ou nervos, a miopatia tem origem no próprio tecido muscular, prejudicando sua capacidade de contrair e gerar movimento.

As miopatias podem ser hereditárias (genéticas) ou adquiridas, e geralmente não envolvem lesão nervosa ou articular como causa primária. Há diferentes tipos:

- **Miopatias inflamatórias**
  Doenças autoimunes que causam inflamação no músculo, levando à fraqueza e dor. Exemplos: Polimiosite e Dermatomiosite.
- **Miopatias metabólicas**
  Relacionadas a defeitos no metabolismo muscular, geralmente por falta de enzimas que processam energia. Exemplo: Glicogenoses (dificuldade de usar glicogênio como combustível) como Doença de Pompe
- **Miopatias tóxicas**
  Causadas por substâncias ou medicamentos que danificam o músculo. Exemplo clássico: uso prolongado de estatinas (remédios para colesterol).
- **Miopatias endócrinas**
  Decorrentes de alterações hormonais que afetam o funcionamento muscular. Exemplo: hipotireoidismo, hipertireoidismo que pode causar fraqueza e fadiga.
- **Miopatias hereditárias**
  Doenças genéticas que alteram a estrutura ou função do músculo. Exemplos: Distrofia muscular de Duchenne e Becker.
- **Miopatias mitocondriais**
  Problemas nas mitocôndrias (responsáveis pela produção de energia), levando à fadiga e fraqueza muscular. Exemplos: síndrome de Kearns-Sayre.

Conforme já disposto, o **torcicolo congênito** é uma alteração estrutural localizada causada por encurtamento ou fibrose do músculo esternocleidomastoideo, muitas vezes associado a posição intrauterina ou trauma no parto. Sendo assim, **não é uma doença primária do tecido muscular como ocorre nas miopatias, não cabendo liberação do 20103344**.

As condutas fisioterapêuticas podem envolver exercícios terapêuticos adaptados (com foco em resistência leve, evitando fadiga excessiva), alongamentos suaves, treino funcional, técnicas respiratórias (especialmente em casos com comprometimento da musculatura respiratória), uso de órteses e adaptações (quando necessário para suporte funcional).

TUSS 50000160 - Atendimento fisioterapêutico ambulatorial ao paciente com disfunção decorrente de alterações do sistema músculo-esquelético

Exemplos de indicação: técnicas osteopáticas para distúrbios funcionais (ex.: refluxo, cólica em bebês); diástase não relacionada à gravidez; ajustes posturais e manipulações para disfunções sem código próprio; intervenções musculoesqueléticas não enquadradas em outros códigos

🎯 Este código se refere ao atendimento fisioterapêutico voltado para disfunções relacionadas ao sistema musculoesquelético, envolvendo avaliação e intervenção por meio de técnicas manuais, exercícios terapêuticos ou recursos específicos.
É utilizado quando não existe outro código TUSS específico para a condição ou técnica empregada, mas há necessidade de abordagem musculoesquelética para restaurar função ou reduzir sintomas.

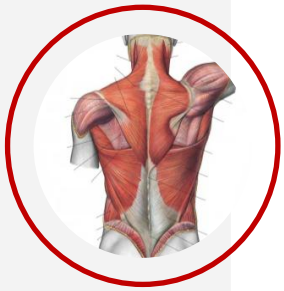
Este código **não deve ser usado para patologias que já possuem código específico** (ex.: miopatias, lesões nervosas periféricas), mas sim para situações em que a disfunção envolve o sistema musculoesquelético e não há outra classificação adequada.

Referente a osteopatia, já abordada neste manual. Quanto à diástase, seguem as disposições:

A **diástase dos retos abdominais** é o **aumento da distância inter-retos (IRD)** devido ao afrouxamento/afinamento da linha alba, resultando em protusão/doming da parede abdominal e disfunção do core (instabilidade lombo-pélvica, dor lombar, alteração postural).

Abrangência (populações)

- **Pós-gestantes**: DRA é comum e pode persistir meses; trata-se como condição funcional do core.
- **Não gestantes** (homens, atletas, pessoas com obesidade, pós-cirurgia abdominal): apresentam quadro semelhante (protusão, fraqueza do core) e **se beneficiam de reabilitação**.



Orientações de codificação TUSS

A. DRA vinculada à gestação (gestantes/ex-gestantes)
→ **TUSS 20103107 – Atendimento fisiátrico no pré e pós-parto**
Justificativa técnica: o quadro está diretamente relacionado ao ciclo gravídico-puerperal; diretrizes reconhecem abordagem conservadora (fisioterapia) como primeira linha.

B. DRA sem relação com gestação (não gestantes)
→ **TUSS 50000160 – Atendimento fisioterapêutico ambulatorial ao paciente com disfunção decorrente de alterações do sistema músculo-esquelético**
Justificativa técnica: a DRA, fora do contexto gestacional, é **disfunção musculoesquelética da parede abdominal** sem código TUSS específico; enquadrando-se neste código por envolver avaliação/ intervenção fisioterapêutica da parede abdominal e do core.

⚠️ **Atenção:** Edema não é característica da diástase dos retos abdominais. A diástase é alteração da linha alba e da parede abdominal; já o edema decorre de distúrbios circulatórios ou inflamatórios. A drenagem linfática pode ser indicada para controle de edema em situações específicas (pós-parto, pós-operatório), mas não há evidência de que reduza a distância inter-retos ou corrija a DRA, razão pela qual o código 20103212 não deve ser liberado para este quadro.

⚠️ A DRA é problema funcional quando há dor, instabilidade, dificuldade em atividades, etc. Objetivos estritamente estéticos (ex.: "flacidez sem disfunção", "redução de medidas", "modelagem corporal") não caracterizam reabilitação funcional da DRA. Verificar aplicação da negativa **N236** junto à consultoria para confirmação.

As condutas fisioterapêuticas incluem:

- **Ativação do transverso do abdome (TrA)** e controle respiratório: exercícios para estabilização do core e sinergia com assoalho pélvico.
- **Treino funcional e correção postural:** progressão segura para atividades de vida diária, evitando aumento da pressão intra-abdominal.
- **Método hipopressivo:** técnica postural e respiratória que reduz pressão intra-abdominal e ativa musculatura profunda; estudos mostram benefício semelhante aos exercícios convencionais para reduzir IRD no pós-parto, podendo ser escolhido por preferência ou aderência da paciente.
- **Alongamentos suaves:** prevenção de retrações musculares e manutenção da amplitude de movimento.
- **Educação postural e manejo de atividades:** evitar manobras que aumentem pressão abdominal (ex.: Valsalva, exercícios de alta carga).
- **Uso de órteses ou faixas abdominais:** efeito modesto, mas pode ser adjuvante para suporte funcional.



TUSS 20103409 - Pacientes com doenças neuro-músculo-esqueléticas com envolvim tegumentar

Exemplos de indicação: Lúpus eritematoso sistêmico (quando houver envolvimento tegumentar); esclerodermia sistêmica (esclerose sistêmica)

🎯 O código 20103409 deve ser utilizado exclusivamente para pacientes que apresentem, **simultaneamente**:

- Doença neuro-músculo-esquelética (envolvendo sistema nervoso, músculos e/ou ossos)
- Alteração funcional ou estrutural relevante do sistema tegumentar (pele e tecidos subcutâneos), como: fibrose cutânea; endurecimento da pele; retrações, aderências ou contraturas relacionadas à pele; lesões cutâneas ou úlceras.

A **esclerodermia sistêmica** é uma doença autoimune caracterizada por fibrose cutânea progressiva, endurecimento da pele e comprometimento musculoesquelético, podendo evoluir com **contraturas articulares e musculares**, dor, rigidez e limitação importante da mobilidade. Pode ser necessário um programa fisioterapêutico com técnicas de cinesioterapia, mobilização miofascial e articular, exercícios funcionais, recursos analgésicos e cuidados específicos com a pele para prevenção de lesões e manejo de áreas de risco.

O **lúpus eritematoso sistêmico** é uma doença autoimune inflamatória e multissistêmica, que pode acometer **articulações, músculos, pele e outros órgãos**. O uso do código 20103409 só é indicado quando houver envolvimento tegumentar, que no caso do lúpus, pode ocorrer: lesões cutâneas extensas ou crônicas, alterações do tecido conjuntivo com repercussão na mobilidade.



Códigos de reeducação e reabilitação neurológica

TUSS 20103077 - Ataxias

Exemplos de indicação: ataxia cerebelar (degenerativa, hereditária ou adquirida); ataxia sensorial (por neuropatia periférica); ataxia pós-AVC; ataxia por esclerose múltipla; ataxia por doenças metabólicas ou tóxicas; ataxia causada por tumores cerebelares ou do sistema nervoso central

🎯 Este código é destinado ao tratamento fisioterapêutico de pacientes com ataxia, condição neurológica caracterizada por falta de coordenação motora, desequilíbrio, instabilidade postural e dificuldade na execução de movimentos voluntários. A ataxia pode ser causada por lesões cerebelares, doenças neurodegenerativas, síndromes genéticas, intoxicações ou sequelas de AVC.

As condutas fisioterapêuticas recomendadas incluem treino de equilíbrio estático e dinâmico, exercícios para coordenação motora, fortalecimento muscular, treino de marcha, treino proprioceptivo.

TUSS 20103204 - Distrofia simpático-reflexa

Exemplos de indicação: SDRC tipo I após fratura de punho, tornozelo ou mão; síndrome de Sudeck; dor persistente com alterações tróficas; dor desproporcional ao trauma; dor crônica pós-trauma sem lesão nervosa

🎯 O termo **Distrofia simpático-reflexa** refere-se a uma condição conhecida atualmente como Síndrome de Dor Regional Complexa tipo I (SDRC I), também chamada de algodistrofia ou algoneurodistrofia.
É uma síndrome caracterizada por dor crônica intensa, geralmente desproporcional ao evento inicial (trauma, cirurgia, imobilização), acompanhada de alterações sensoriais, motoras, vasomotoras e tróficas (pele, pelos, unhas). Ocorre após lesão ou trauma, mas sem lesão nervosa identificável (quando há lesão de nervo, é chamada de SDRC tipo II).
Os sintomas principais são:

- Dor persistente e intensa (alodinia, hiperestesia)
- Edema local
- Alterações de cor e temperatura da pele
- Sudorese alterada
- Diminuição da mobilidade
- Atrofia muscular e óssea
- Alterações tróficas (pele fina, unhas quebradiças)

As condutas podem envolver controle da dor (termoterapia, crioterapia, eletroterapia), exercícios ativos e passivos, mobilização suave, dessensibilização sensorial, treino funcional, hidroterapia.



TUSS 20103425 - Paralisia cerebral

Exemplos de indicação: paralisia cerebral espástica (hemiparética, diparética, tetraparética); paralisia cerebral discinética (distônica, coreoatetósica), paralisia cerebral atáxica, paralisia cerebral mista

🎯 Paralisia cerebral (PC) é um grupo de distúrbios permanentes do desenvolvimento do movimento e da postura, causados por lesão não progressiva do cérebro imaturo, geralmente ocorrida durante a gestação, parto ou nos primeiros anos de vida. A PC pode afetar a força, o tônus muscular, a coordenação, o equilíbrio, a marcha e, em alguns casos, a fala, visão e cognição.

Os principais tipos clínicos de PC são:

- Espástica: caracteriza-se por hipertonia, ou seja, o aumento do tônus muscular (rigidez e dificuldade de movimento devido à contração constante dos músculos), podendo afetar um lado do corpo (hemiparética), ambos os membros inferiores (diparética) ou todos os membros (tetraparética).
- Discinética: marcada por movimentos involuntários, podendo ser predominante distônica (movimentos de torção e postura anormal) ou coreoatetósica (movimentos irregulares, lentos e contorcidos).
- Atáxica: predomina a falta de coordenação motora, desequilíbrio e dificuldade na execução de movimentos precisos.
- Mista: apresenta combinação de dois ou mais padrões motores acima.

As condutas envolvem treino motor global e funcional, estimulação sensório-motora, treino de habilidades de vida diária, técnicas específicas como: facilitação neuromuscular proprioceptiva (FNP), método Bobath, treino com terapia de espelho, terapia por contensão induzida.
⚠️ Muita atenção para a probabilidade de **fisioterapia domiciliar**, devido à dificuldade de locomoção do paciente!

TUSS 20103441 - Paraparesia/tetraparesia

Exemplos de indicação: lesão medular traumática (fratura, acidente automobilístico, queda); mielopatia cervical ou torácica (compressão medular por hérnia de disco, estenose, tumor); tumores do sistema nervoso central (medula espinhal, tronco cerebral); infecções do SNC (mielite transversa, abscesso medular; poliomielite com sequelas motoras parciais; paraparesia espástica hereditária; paraparesia/tetraparesia pós-AVC extenso com preservação parcial de movimentos

🎯 Redução parcial da força muscular em membros inferiores (paraparesia) ou em todos os membros (tetraparesia), geralmente por lesão neurológica, geralmente por lesão neurológica, mantendo algum grau de funcionalidade.



Condutas:

- Fortalecimento muscular adaptado à capacidade residual.
- Treino de marcha com órteses, barras paralelas ou dispositivos robóticos.
- Alongamentos para prevenção de contraturas.
- Treino funcional (transferências, posicionamento, AVDs).
- Recursos complementares: eletroestimulação, hidroterapia, treino de equilíbrio.

⚠️ Muita atenção para a probabilidade de **fisioterapia domiciliar**, devido à dificuldade de locomoção do paciente!



TUSS 20103450 - Paraplegia e tetraplegia

Exemplos de indicação: lesão medular completa (trauma, fratura vertebral com secção medular); mielite transversa extensa; tumores medulares com destruição completa da via motora; lesão traumática cervical alta (tetraplegia); infecções graves do SNC com destruição medular; sequelas de acidentes automobilísticos com lesão medular completa

🎯 Perda completa da função motora voluntária em membros inferiores (paraplegia) ou em todos os membros (tetraplegia), geralmente associada a lesão medular completa.

Condutas:

- **Mobilizações passivas**: para prevenção de contraturas e manutenção da amplitude articular.
- **Posicionamento adequado**: para evitar úlceras de pressão e deformidades.
- **Treino respiratório**: essencial em tetraplegia (fortalecimento diafragmático, técnicas de expansão torácica).
- **Treino funcional adaptado**: foco em independência com cadeira de rodas, transferências com auxílio, uso de dispositivos.
- **Controle de espasticidade**: alongamentos prolongados, técnicas inibitórias.
- **Tecnologias assistivas**: adaptação de dispositivos para comunicação, alimentação e mobilidade.

⚠️ Muita atenção para a probabilidade de **fisioterapia domiciliar**, devido à dificuldade de locomoção do paciente!



TUSS 20103468 - Parkinson

Exemplos de indicação: doença de Parkinson idiopática; síndromes parkinsonianas secundárias (ex.: pós-encefalite, uso crônico de neurolépticos); parkinsonismo vascular (lesões múltiplas em substância branca)

🎯 A Doença de Parkinson é uma patologia neurodegenerativa crônica e progressiva, caracterizada pela degeneração das células dopaminérgicas da substância negra no mesencéfalo, levando à redução da dopamina nos núcleos da base. Essa alteração provoca distúrbios motores e não motores, com impacto significativo na funcionalidade e qualidade de vida.
Os principais sinais motores incluem:

- Bradicinesia (lentidão dos movimentos) – sintoma mais característico.
- Rigidez muscular (aumento do tônus).
- Tremor de repouso (geralmente unilateral no início).
- Instabilidade postural (risco elevado de quedas).

Além dos sintomas motores, podem ocorrer alterações cognitivas, depressão, distúrbios do sono e disfunções autonômicas, que agravam a dependência funcional.

Condutas recomendadas

- Treino de marcha com pistas visuais e auditivas para superar congelamento (cueing).
- Exercícios de amplitude e alongamento para reduzir rigidez e melhorar mobilidade.
- Treino de equilíbrio e prevenção de quedas, com estratégias compensatórias.
- Exercícios aeróbicos (bicicleta, caminhada supervisionada) para capacidade funcional.
- Treino funcional para AVDs (vestir-se, higiene, alimentação), com técnicas adaptativas.

⚠️ Muita atenção para a probabilidade de **fisioterapia domiciliar**, principalmente em estágios moderados a avançados!

TUSS 20103476 - Patologia neurológica com dependência de atividades da vida diária

Exemplos de indicação: AVC extenso com dependência total; demências (ex.: Alzheimer, demência vascular, demência por corpos de Lewy, mista); esclerose múltipla; Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA)

🎯 **Quadros neurológicos graves** que resultam em dependência significativa ou total para atividades básicas da vida diária (AVDs), como alimentação, higiene, mobilidade e comunicação. Geralmente associados a lesões extensas ou doenças neurodegenerativas em estágio avançado, sem perspectiva de recuperação funcional significativa.

Esses pacientes apresentam limitação severa, exigindo cuidados contínuos e abordagem voltada para prevenção de complicações, conforto e qualidade de vida, mais do que ganho motor.

Condutas recomendadas

- Mobilizações passivas para prevenção de contraturas e manutenção mínima da amplitude articular.
- Posicionamento adequado para evitar úlceras de pressão e deformidades.
- Estimulação sensorial para conforto e interação.

⚠️ Existe **alta probabilidade de atendimento domiciliar** devido à dificuldade extrema de locomoção.



Códigos de reeducação e reabilitação no retardo do desenvolvimento psicomotor

TUSS 20103689 - Retardo do desenvolvimento psicomotor

Exemplos de indicação: síndromes genéticas com atraso motor (ex.: Síndrome de Down); retardo global do desenvolvimento por prematuridade extrema; atraso motor idiopático (sem causa definida); autismo/TEA com atraso motor

🎯 Condição caracterizada por atraso significativo na aquisição de marcos motores esperados para a idade, como controle postural, marcha, coordenação motora fina e grossa. Pode estar associada a causas neurológicas, genéticas, metabólicas ou ambientais. O diagnóstico é clínico, baseado em avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor.

Condutas recomendadas

- **Estimulação motora precoce**: exercícios para controle postural, rolar, sentar, engatinhar.
- **Treino de marcha**: com suporte parcial, órteses ou dispositivos adaptados.
- Fortalecimento muscular: atividades lúdicas e funcionais.
- Treino de coordenação motora fina e grossa.
- Recursos complementares: hidroterapia, eletroestimulação (quando indicado).

⚠️ Muita atenção para a probabilidade de **fisioterapia domiciliar**, devido à dificuldade de locomoção do paciente!

TUSS 50000012 - Sessão de psicomotricidade individual

Exemplos de indicação: retardo do desenvolvimento psicomotor (sem causa definida); transtorno do espectro autista (TEA) com comprometimento motor; síndromes genéticas com atraso motor e dificuldades de integração corporal; alterações psicomotoras secundárias a privação de estímulo; distúrbios de aprendizagem associados a déficit psicomotor; sequelas leves de traumatismo cranioencefálico com impacto psicomotor

🎯 Intervenção terapêutica baseada nos princípios da psicomotricidade, que integra aspectos motores, cognitivos e emocionais para promover o desenvolvimento global da criança ou reabilitação do adulto. Trabalha a relação entre movimento, corpo e mente, visando melhorar coordenação, equilíbrio, esquema corporal, lateralidade e organização espacial.
É uma abordagem terapêutica que integra **movimento, cognição e emoção**, trabalhando a relação entre corpo e mente.
O objetivo não é apenas força ou amplitude (como na fisioterapia), nem apenas aspectos emocionais e comportamentais (como na psicoterapia), mas **a organização global do indivíduo através do movimento**.
Atua em coordenação motora, equilíbrio, esquema corporal, lateralidade, orientação espacial e integração sensorial, sempre com atividades lúdicas e interativas.



Condutas recomendadas

- **Atividades lúdicas estruturadas**: jogos que estimulam coordenação motora fina (ex.: encaixes, desenho) e grossa (ex.: circuitos, saltos).
- **Exercícios de equilíbrio e postura**: caminhar sobre linhas, superfícies instáveis, uso de bolas terapêuticas.
- **Trabalho de lateralidade e orientação espacial**: movimentos cruzados (braço direito com perna esquerda), jogos de direita/esquerda.
- **Estimulação do esquema corporal**: atividades com espelho, percepção tátil, nomeação de partes do corpo.
- **Integração sensorial**: uso de texturas, sons, movimentos rítmicos para melhorar percepção e resposta motora.
- **Atividades simbólicas**: brincadeiras que envolvem imaginação e representação (ex.: "faz de conta"), para integrar emoção e movimento.

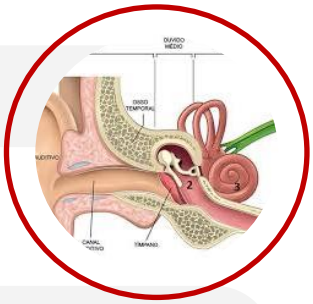
Orientações:

Para apólices adaptadas à nova legislação, **com ou sem aditivo para psicomotricidade**:

- Se realizado por fisioterapeuta: liberar conforme código 50000012.
- No entanto, se já estivermos pagando como 20103689 (REEDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO NO RETARDO DO DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR) há mais de um ano, manteremos este código. Nos casos em que liberamos há menos tempo, compartilhar com consultor para avaliação.

⚠️ Se realizado por psicomotricista (ou seja, profissional que não é fisioterapeuta) **e houver aditivo para psicomotricidade**, podemos liberar, pois o estipulante contratou a cobertura.

Código de reabilitação labiríntica



TUSS 20103638 - Reabilitação labiríntica (por sessão)

Exemplos de indicação: Vertigem Posicional Paroxística Benigna (VPPB); doença de Ménière; neurite vestibular; hipofunção vestibular unilateral ou bilateral; labirintite; tontura crônica de origem vestibular; desequilíbrio pós-trauma craniano; síndrome vestibular periférica ou central compensada

🎯 A **Reabilitação Labiríntica** é um conjunto de exercícios terapêuticos destinados a promover a compensação vestibular em pacientes com disfunções do sistema vestibular (labirinto). Essas disfunções ocorrem quando há **alteração na função sensorial do ouvido interno**, responsável pelo equilíbrio, podendo resultar em **vertigem, instabilidade postural, desequilíbrio e náuseas**.

O sistema vestibular pode ser comprometido por:

- **Lesões periféricas** (no labirinto ou nervo vestibular), como:
  - Inflamações (labirintite, neurite vestibular)
  - Degeneração (hipofunção vestibular)
  - Cristais deslocados (VPPB)
- **Doenças metabólicas ou vasculares** (ex.: diabetes, hipertensão)
- **Traumas cranianos**
- **Doenças autoimunes ou infecciosas**
- **Alterações centrais** (lesões cerebelares ou tronco encefálico)

Essas alterações reduzem a capacidade do cérebro de integrar informações sensoriais (visual, vestibular e proprioceptiva), gerando sintomas incapacitantes. A reabilitação atua estimulando mecanismos de **adaptação, habituação e substituição sensorial**, acelerando a compensação neural e melhorando a qualidade de vida.

Protocolos mais comuns incluem:

- **Exercícios de Adaptação Vestibular:** movimentos cefálicos repetitivos para estimular o reflexo vestíbulo-ocular (VOR)
- **Exercícios de Habitação:** exposição gradual a movimentos que provocam sintomas para reduzir a sensibilidade
- **Exercícios de Substituição:** uso de pistas visuais e proprioceptivas para compensar déficit vestibular
- **Manobras Específicas** para VPPB: Manobra de Epley, Semont, Brandt-Daroff,
  - Dix-Hallpike é teste diagnóstico para VPPB, que identifica deslocamento dos otólitos (cristais) nos canais semicirculares, geralmente no canal posterior, e orienta a escolha da **manobra terapêutica**.
- **Treino de Equilíbrio e Marcha** em superfícies estáveis e instáveis

Orientações:
As manobras descritas possuem cobertura quando realizadas por **fisioterapeuta** ou médico fisiatra. Se cobradas por médico de outra especialidade, negar com N226 RN465 para apólices da lei. Se cobrado por fonoaudiólogo, liberar como sessão de fonoaudiologia.

Códigos de exercícios de ortóptica

TUSS 20103239 - Exercícios de ortóptica (por sessão)

Exemplos de indicação: estrabismo (principalmente intermitente); ambliopia (olho preguiçoso); insuficiência de convergência (dificuldade para focar objetos próximos); diplopia (visão dupla); distúrbios da visão binocular e percepção de profundidade

🎯 São técnicas terapêuticas que funcionam como uma "fisioterapia para os olhos", com o objetivo de reabilitar a visão binocular, melhorar a coordenação ocular e corrigir desequilíbrios musculares dos olhos. Atuam sobre os músculos extrínsecos oculares e o sistema neurossensorial, promovendo alinhamento e sincronia entre os olhos.

Pode ser cobrado como estímulo visual realizado por fisioterapeuta. Neste caso, liberar conforme 20103239. Liberamos para fisioterapeuta, fisiatra e oftalmologista.



Esse atendimento pertence ao subgrupo reabilitação física. Se cobrado por Ortoptista, negar N226.
São feitos:

Exercícios de Convergência
- Atividades que treinam os olhos para se aproximarem e focarem objetos próximos.
- **Exemplo:** Barbante de Brock (o paciente fixa a visão em contas dispostas em um barbante, ajustando a convergência).

Exercícios de Fusão
- Técnicas para que os dois olhos trabalhem juntos formando uma única imagem.
- **Exemplo:** Cartões de fusão ou estereogramas, onde o paciente precisa fundir duas imagens em uma.

Exercícios de Divergência
- Treinos para afastar os olhos e focar objetos distantes, melhorando a coordenação ocular.
- **Exemplo:** Alternar foco entre objetos próximos e distantes.

Técnicas de Fixação
- Exercícios para melhorar a estabilidade do olhar em um ponto específico, evitando movimentos involuntários.
- **Exemplo:** Fixar a visão em um alvo pequeno por tempo prolongado.

TUSS 20103743 - Exercícios de pleóptica

Exemplos de indicação: ambliopia profunda com fixação excêntrica; Baixa visão sem causa orgânica grave

🎯 **Pleóptica** é uma técnica terapêutica visual voltada para tratamento da ambliopia (popularmente chamada "olho preguiçoso"), especialmente em casos graves ou com fixação excêntrica. Seu objetivo é estimular a mácula e reeducar a fixação central, melhorando a acuidade visual do olho afetado.

É considerada uma terapia ativa, diferente do tratamento passivo com tampão, e geralmente associada à oclusão ocular (tampar o olho dominante [o que enxerga melhor] para forçar o uso do olho afetado, estimulando sua função visual. Assim como a ortóptica, há cobertura somente para fisiatra, fisioterapeuta, pois está no subgrupo Reabilitação do ROL da ANS, além do oftalmologista.

Estimulação luminosa da mácula
- Uso de luzes direcionadas para ativar a área central da retina do olho amblíope.
- Objetivo: romper padrão de fixação excêntrica.

Exercícios com filtros e tampões
- Oclusão do olho dominante para forçar o uso do olho afetado.
- Pode incluir filtros translúcidos para modulação do estímulo.

Programas computadorizados interativos
- Softwares com jogos visuais para estimular percepção e fixação central.

Biofeedback visual
- Equipamentos que monitoram a fixação e fornecem feedback em tempo real para melhorar controle ocular.

Associação com terapia ortóptica
- Exercícios de fusão e convergência para complementar a reabilitação binocular.

Código de reeducação e reabilitação de queimados para prevenção de sequelas

TUSS 20103611 - Queimados - seguimento ambulatorial para prevenção de sequelas (por segmento)

Exemplos de indicação: pacientes pós-queimadura de qualquer grau que apresentem: cicatrizes hipertróficas ou queloides, áreas de retração cicatricial, limitação de amplitude articular, risco de deformidades funcionais, alterações sensoriais ou dor crônica

🎯 O seguimento ambulatorial para prevenção de sequelas em pacientes queimados consiste em acompanhamento clínico e terapêutico após a alta hospitalar ou término do tratamento inicial da fase aguda, com foco na recuperação funcional e prevenção de complicações tardias, como contraturas, deformidades e cicatrizes hipertróficas.

As queimaduras conforme classificação:

- **1º grau (superficial):** geralmente não requer seguimento prolongado
- **2º grau (parcial ou profundo):** maior risco de cicatrizes hipertróficas e limitação funcional, especialmente em áreas articulares.
- **3º grau (total):** alto risco de contraturas, deformidades e necessidade de enxertos, exigindo acompanhamento intensivo.
- **Queimaduras elétricas ou químicas:** podem causar lesões profundas e sequelas significativas.

As condutas podem envolver controle de edema e posicionamento, treino funcional, pressão/compressão para cicatriz hipertrófica, mobilização, alongamentos e prevenção de contraturas, massagem cicatricial



Códigos de reabilitação em amputação (preparação do coto e treinamento protético)



TUSS 20103042 - Amputação unilateral (preparação do coto)
TUSS 20103026 - Amputação bilateral (preparação do coto)

Cuidados pós-cirúrgicos para cicatrização, controle de edema, modelagem do coto, prevenção de contraturas e fortalecimento para futura protetização.

Condutas principais:

- Enfaixamento compressivo para modelagem do coto.
- Mobilização e alongamentos para evitar contraturas.
- Fortalecimento muscular.
- Orientações sobre higiene e cuidados com pele.
- Treino funcional inicial (transferências, equilíbrio sentado).

TUSS 20103034 - Amputação bilateral (treinamento protético)
TUSS 20103050 - Amputação unilateral (treinamento protético)

Treino funcional com prótese para marcha, equilíbrio, atividades de vida diária e adaptação progressiva ao dispositivo.

Condutas principais:

- Treino de colocação e retirada da prótese.
- Ajuste do padrão de marcha (membros inferiores).
- Treino funcional para AVDs (membros superiores).
- Orientações sobre cuidados com coto e prótese.
- Progressão do tempo de uso da prótese.

UTILIZAÇÃO DE CRÍTICAS

Para algumas críticas negativas, foi disposta nesta seção apenas a versão para as apólices da lei/adaptadas. Para verificar as críticas correspondentes das apólices pré-lei, pesquisar na tabela de críticas constante no Infohub.

A107: utilizar para perguntarmos qual técnica foi realizada pelo prestador, pois pode haver cobrança de técnicas não realizadas de fato ou de técnicas não cobertas.

A107 - A: além de perguntar qual técnica, esta serve para questionar a região corporal de aplicação dela, podendo nortear a liberação do código. É aplicável, também, em alguns casos de estimulação elétrica transcutânea que pode ter sido aplicada em região corporal excluída pela DUT.

A116 - FISIOTERAPIA: utilizar quando o pedido médico não tiver sido apresentado em momento algum.

A116-A: utilizar quando o pedido médico não descrever o quadro clínico, sintomatologias, CIDS´s que indicaram o tratamento.

A170: utilizar em casos (principalmente em cobrança abusiva) em que o terapeuta cobrou várias abordagens, mas não discriminou valores de cada. Por exemplo: além do código de patologia, técnicas não cobertas como: Atividade de Escola de postura / Manipulação vertebral / cinesioterapia específica (Pilates) / laserterapia / ondas de choque. Assim, podemos pagar os valores da fisioterapia convencional e negar os valores das demais técnicas.

A195: utilizar quando o prazo do pedido médico estiver expirado.

A196: utilizar quando houver nº de sessões programadas no pedido médico e essa quantidade já tiver sido utilizada pelo segurado.

A197: utilizar quando o encaminhamento médico não possuir data de emissão.

A198: utilizar quando o pedido médico estiver com carimbo e assinaturas colados (produzidos no WORD e salvos em PDF).

A201: utilizar nos contextos de suspeita de fraude, solicitando o laudo de exames de imagem com base na patologia que motivaram a terapia.

A205 C - relatório prestador com colagem: pode ser usado para casos suspeitos e com clara colagem no relatório do prestador do serviço.

A205 D - assinatura eletrônica prestador: pode ser usado para casos suspeitos e que não foi possível validar a assinatura eletrônica do prestador do serviço.

A206 A - indicação para a técnica: utilizar para solicitar indicação médica para a técnica específica cobrada pelo prestador.

A225 - CONSULTA FISIOTERAPIA: solicitação de justificativa para cobrança de consulta seriada de fisioterapeuta.

N205 RN 465 - Lei 9656: para procedimentos fora do ROL em apólice da lei.

N213 RN 465 - Lei 9656: para tratamentos experimentais. Apólice da lei.

N214 RN 465 - Lei 9656: para atendimentos feitos por profissionais de saúde que não são habilitados a fazê-los. Apólice da Lei.

N225: utilizar nas apólices anteriores a lei, sem adaptação e sem aditivos, quando a indicação da terapia for doença e não acidente pessoal. No Livre Escolha, verificar o contrato antes de utilizá-la.

N226 RN 465: utilizar quando o tratamento fisioterápico/de reabilitação for realizado por outros profissionais que não fisioterapeuta e médico fisiatra (ex.: educadores físicos, médicos ortopedistas, entre outros). Apólice da lei.

N236 RN 465 - Lei 9656: Pode ser usada para procedimentos que, embora constem no ROL, foram realizados para fins estéticos. Apólice da lei.

N253 RN 465 - Lei 9656: utilizada para negar prótese e órtese não implantada cirurgicamente. Apólice da lei.

N294 RN 465 - Lei 9656: para procedimentos fora da Diretriz de Utilização da ANS. Somente para apólices da lei.

N302 RN 465 / Hosp / Lei 9656: utilizar para cobrança para apólices hospitalares, de fisioterapia que não se trate de continuidade de atendimento prestado em ambiente de internação. Apólice da Lei.

N336 Pré-lei: para procedimentos que não constam na tabela de honorários e serviços médicos. Para apólice pré-lei.

N340 RN 465 - Lei 9656: para atendimentos feitos por profissionais que não são da área da saúde.

N353: utilizar quando houver cobrança de sessões de fisioterapia online (obs.: utilização para eventos anteriores à nova resolução do COFFITO. Ver a seção Atendimentos Online deste manual).

N415 - técnica não solicitada: utilizar para valores cobrados em recibos separados de técnicas não solicitadas pelo médico. Ver utilização descrita neste manual.

N433 - FISIOTERAPIA P/ TRANSTORNOS MENTAIS: para fisioterapia não realizada para patologias físicas, e sim mentais/emocionais.